Protocolo de Atenção à Saúde

PROTOCOLO PARA O CUIDADO FARMACÊUTICO À PESSOA COM TUBERCULOSE E INFECÇÃO LATENTE PELO *Mycobacterium tuberculosis*

Área(s): DIASF/SULOG/SEGEA/SES

Portaria SES-DF Nº 709 de 22 de setembro de 2026 publicada no DODF Nº 177 de 23.09.2026.

LISTA DE ABREVIATURAS

APS - Atenção Primária à Saúde
ARV- antirretrovirais
BVS - Biblioteca Virtual em Saúde
CFF - Conselho Federal de Farmácia
CIAP-2 - Classificação Internacional para Atenção Primária
CID-10 - Classificação Internacional de Doenças
CSP - Cuidados de Saúde Primários
DCB - Denominação Comum Brasileira
DF - Distrito Federal
DFC - Dose fixa combinada
E - Etambutol
e-SUS APS - e-SUS Atenção Primária à Saúde
H - Isoniazida
HUB - Hospital Universitário
IGRA - teste de liberação de interferon-gama
ILTB - infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis
LF-LAM - fluxo lateral para lipoarabinomanano
MS - Ministério da Saúde
NE - Não especificado de outra forma
OMS - Organização Mundial da Saúde
PDAF - Política Distrital de Assistência Farmacêutica
PIC - Práticas Integrativas e Complementares
PNAF - Política Nacional de Assistência Farmacêutica
PNH - Política Nacional de Humanização
PRM - Problema relacionado a medicamento
PT - Prova Tuberculínica
PTS - Projeto Terapêutico Singular
R - Rifampicina
RDC - Resolução da Diretoria Colegiada
SES-DF - Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SUS - Sistema Único de Saúde
TB - Tuberculose
TBDR - Tuberculose drogarresistente
TDO - Tratamento diretamente observado
TPT - Tratamento Preventivo da Tuberculose
TRM-TB - Teste rápido molecular para tuberculose
TS - Teste de sensibilidade
UBS - Unidade Básica de Saúde
URM - uso racional de medicamentos
Z - Pirazinamida

SUMÁRIO

1. Metodologia de Busca da Literatura 5
   1.1. Bases de dados consultadas 5
   1.2. Palavra(s) chaves(s) 5
   1.3. Período referenciado e quantidade de artigos relevantes 5
2. Introdução 5
3. Justificativa 6
4. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 7
5. Diagnóstico Clínico ou Situacional 8
6. Critérios de Inclusão 8
7. Critérios de Exclusão 8
8. Conduta 9
   8.1. Fluxo de acesso da pessoa com TB ou ILTB aos serviços clínicos providos por farmacêuticos 9
   8.2. Cuidado Farmacêutico 10
   8.3. Conduta Preventiva 11
      8.3.1 Educação em saúde 11
      8.3.2 Rastreamento em saúde 11
   8.4. Conduta Geral 12
      8.4.1 Anamnese farmacêutica 12
      8.4.2 Análise técnica da prescrição 13
      8.4.3 Revisão da farmacoterapia 13
      8.4.3.1 Avaliação da indicação 14
      8.4.3.2 Avaliação de efetividade 15
      8.4.3.3 Avaliação de segurança 19
      8.4.4. Consulta farmacêutica 20
      8.4.5. Acompanhamento farmacêutico 23
      8.4.6. Prevenção e identificação de erros de medicação 24
      8.4.7. Prescrição farmacêutica 25
      8.4.8. Dispensação 25
      8.4.9. Orientações Farmacêutica de alta 26
      8.4.10. Gestão da Condição de Saúde 26
      8.4.11. Educação em saúde 27
      8.4.12. Prevenção, detecção e notificação de eventos adversos relacionados aos medicamentos 29
      8.4.13. Detecção e notificação de desvio de qualidade de medicamentos 31
   8.5. Tratamento Não Farmacológico 31
      8.5.1. Práticas Integrativas em Saúde 31

8.6. Tratamento Farmacológico 32
8.5.1. Fármaco(s) 32
8.5.2. Esquema de Administração 33
8.5.3. Tempo de Tratamento – Critérios de Interrupção 38
9. Benefícios Esperados 39
10. Monitorização 39
10.1 Avaliação de qualidade de vida 40
11. Acompanhamento Pós-tratamento 40
12. Termo de consentimento informado – TCI 41
13. Regulação/Controle/Avaliação pelo Gestor 41
14. Referências Bibliográficas 45

1. METODOLOGIA DE BUSCA DA LITERATURA

1.1. Bases de dados consultadas

Foram realizadas consultas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

1.2. Palavra(s) chaves(s)

Tuberculose, Tuberculose Latente, Tuberculose Pulmonar, assistência farmacêutica (DeCS).

1.3. Período referenciado e quantidade de artigos relevantes

Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, em português, inglês e espanhol, que abordam o cuidado farmacêutico ou manejo terapêutico da tuberculose em contexto clínico e de saúde pública. Foram excluídos estudos sem acesso ao texto completo, relatos de casos isolados e publicações não científicas.

2. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, que acomete principalmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos e sistemas (Brasil, 2019). Trata-se de uma doença de alta relevância epidemiológica, que permanece entre os principais desafios de saúde pública no Brasil e no mundo em razão de sua elevada transmissibilidade, morbidade e impacto social. Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, o controle da doença ainda enfrenta desafios como o abandono terapêutico, a resistência aos fármacos e a coinfecção por HIV (Brasil, 2025).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é considerado um dos países prioritários para o enfrentamento da TB e da coinfecção TB-HIV e está entre os 30 países com maior carga da doença no mundo. Na região das Américas, o país é responsável por aproximadamente 30% de todos os casos notificados.

A eliminação da TB como problema de saúde pública requer não apenas o diagnóstico e tratamento oportuno das pessoas com a forma ativa da doença, mas também a identificação e o cuidado adequado das pessoas com infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB). Estima-se que cerca de um quarto da população mundial esteja infectada pelo bacilo e a prevenção da progressão para a doença ativa constitui uma estratégia essencial para o controle da TB no país (Brasil, 2025; WHO, 2024).

Espera-se, com este protocolo, ter a padronização e a qualificação da atuação farmacêutica no acompanhamento e cuidado às pessoas com TB e ILTB no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), promovendo maior segurança, eficácia, acesso e humanização no tratamento, alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde (MS), bem como aos demais documentos normativos e também aos normativos técnicos do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da SES-DF.

3. JUSTIFICATIVA

O cuidado farmacêutico às pessoas com TB contribui pelo fim da doença como problema de saúde pública, ao oferecer um conjunto de ações que visam garantir o uso seguro, racional e responsável dos medicamentos, além de promover, proteger e recuperar a saúde das pessoas com TB e suas famílias e comunidade. As ações de cuidado farmacêutico são capazes de promover a redução de mortalidade e morbidade, dos casos de TB resistente aos medicamentos e de transmissão da doença, além de melhorar os indicadores de cura. A atuação do farmacêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), Política Distrital de Assistência Farmacêutica (PDAF) e da Política Nacional de Humanização (PNH), contribui para o fortalecimento das ações multiprofissionais e para a integralidade do cuidado (CNS, 2024; CSDF, 2023; Brasil, 2007).

Além disso, no ano de 2026 foi publicado, pelo MS, o Guia para o Cuidado Farmacêutico na Tuberculose (Brasil, 2026), que traz sugestões de como farmacêuticos podem atuar no SUS para enfrentar a TB em seus territórios.

Assim, este protocolo foi desenvolvido com os objetivos de:

- Normatizar e institucionalizar a prescrição farmacêutica, para o tratamento da ILTB, também denominado Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT), em conformidade à Nota Informativa nº 15/2024-CGTM/DATHI/SVSA/MS, do MS, a qual reconhece e orienta a atuação do farmacêutico nesse processo assistencial;
- Respaldar a solicitação, no âmbito da SES-DF, dos exames necessários à investigação da ILTB, como o teste de liberação de interferon-gama (IGRA), o teste tuberculínico ou a prova tuberculínica (PT) e o raio-X de tórax;
- Respaldar a solicitação, no âmbito da SES-DF, dos exames necessários à investigação da TB, como o teste de fluxo lateral para lipoarabinomanano (LF-LAM), o teste rápido molecular para TB (TRM-TB), a baciloscopia, a cultura e o teste de sensibilidade (TS), além da testagem para o HIV;
- Padronizar os serviços clínicos executados por farmacêuticos do DF, oferecendo diretrizes objetivas para os profissionais da SES-DF;
- Promover uma prática farmacêutica baseada em evidências e em conformidade com as políticas públicas de saúde;
- Promover o uso seguro e racional de medicamentos;
- Promover a adesão à farmacoterapia por meio do acompanhamento sistemático, educação em saúde e identificação de barreiras ao tratamento;
- Capacitar os farmacêuticos para atuarem com mais segurança e assertividade na prática clínica;

- Fortalecer o cuidado integral ao paciente, prezando pela individualização do cuidado farmacêutico, favorecendo o seguimento a fim de evitar a interrupção do tratamento e para o bom desfecho do tratamento;
- Promover a interdisciplinaridade entre os diversos profissionais de saúde promovendo um diálogo e troca de saberes para resolver um problema comum, integrando conhecimento de forma recíproca; e
- Reforçar que todo farmacêutico, assim como outros profissionais de saúde, deve notificar casos confirmados de tuberculose no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), após o diagnóstico por critérios laboratorial ou clínico, bem como registrar e acompanhar no IL-TB todo usuário que for iniciar o tratamento preventivo da tuberculose.

4. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)

- **A15** – Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica
- **A16** – Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica
- **A17** – Tuberculose do sistema nervoso
- **A18** – Tuberculose de outros órgãos
- **A19** – Tuberculose miliar
- **J65** – Pneumoconiose associada com tuberculose
- **K93.0** – Transtornos devido à tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios do mesentério
- **M49.0** – Espondilite tuberculosa (Tuberculose da coluna vertebral)
- **M90.0** – Osteíte tuberculosa
- **N74.0** – Tuberculose do colo do útero
- **N74.1** – Doença inflamatória pélvica tuberculosa feminina
- **O98.0** – Tuberculose que complica gravidez, parto e puerpério
- **P37.0** – Tuberculose congênita
- **Z22.7** – Portador de tuberculose latente
- **Z03.0** – Observação por suspeita de tuberculose

4.1. Códigos CIAP-2 recomendados para uso pelo farmacêutico

- **A70** – Tuberculose

Para fins de registro das ações e acompanhamentos no prontuário eletrônico do e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS), os profissionais farmacêuticos devem utilizar a Classificação Internacional para Atenção Primária (CIAP-2), que permite o registro de condições de saúde, condutas e intervenções realizadas no âmbito da prática clínica.

A correta utilização dos códigos CIAP-2 no registro das evoluções farmacêuticas contribui para a integralidade do cuidado, visibilidade das ações do profissional farmacêutico e qualificação das informações em saúde no sistema de informação do SUS.

5. DIAGNÓSTICO CLÍNICO OU SITUACIONAL

O diagnóstico clínico da TB e da ILTB será realizado por profissional médico e enfermeiro, conforme protocolos vigentes.

Já o profissional farmacêutico, conforme respaldado pela Resolução do CFF nº 586 de 29 de agosto de 2013 e Nota Informativa nº 15/2024-CGTM/DATHI/SVSA/MS, pode, respeitando os limites legais de cada profissão de saúde:

I. Solicitar o IGRA para investigação da ILTB;
II. Solicitar, realizar e ler o teste tuberculínico ou PT para investigação da ILTB;
III. Solicitar o raio-X de tórax com laudo para exclusão de TB ativa;
IV. Solicitar a baciloscopia de escarro para acompanhamento de tratamento;
V. Solicitar o TRM-TB para monitoramento das resistências aos antimicrobianos;
VI. Solicitar a cultura e o TS para acompanhamento de tratamento e monitoramento das resistências aos antimicrobianos;
VII. Solicitar e realizar o teste LF-LAM (disponibilizado somente em unidades de atenção ambulatorial especializada);
VIII. Prescrever o TPT;
IX. Execução de serviços de cuidado farmacêutico.

6. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Pessoa com diagnóstico de tuberculose (TB) sensível e Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB).

7. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Pessoa com diagnóstico de tuberculose drogarresistente (TBDR) e esquemas especiais de tratamento.

8. CONDUTA

O cuidado farmacêutico dentro da SES-DF é um processo integrado que envolve diversas etapas, desde o primeiro contato até o acompanhamento contínuo. O papel do farmacêutico é fundamental nesse percurso, especialmente no que tange ao uso seguro e racional de medicamentos. Os serviços clínicos, providos por farmacêuticos, aplicáveis a este Protocolo incluem:

- Acompanhamento farmacoterapêutico;
- Análise técnica da prescrição;
- Anamnese farmacêutica;
- Consulta farmacêutica;
- Detecção e notificação de desvio de qualidade de medicamentos;
- Dispensação;
- Educação em saúde;
- Gestão da condição de saúde;
- Orientação Farmacêutica de Alta;
- Práticas Integrativas em Saúde;
- Prescrição farmacêutica;
- Prevenção e identificação de erros de medicação;
- Prevenção, detecção e notificação de eventos adversos relacionados aos medicamentos;
- Rastreamento em saúde; e
- Revisão da farmacoterapia.

8.1. Fluxo de acesso da pessoa com TB ou ILTB aos serviços clínicos providos por farmacêuticos

O acesso aos serviços farmacêuticos pode ocorrer tanto de forma passiva (demanda espontânea), quanto ativa e organizada (encaminhamentos e busca ativa), conforme a seguir:

1) Demanda espontânea, quando a pessoa com TB ou ILTB procura diretamente o serviço farmacêutico, seja na dispensação, na orientação ou para tirar dúvidas sobre medicamentos, reações adversas ou adesão ao tratamento;
2) Busca ativa e rastreamento, quando há a atuação do farmacêutico na identificação de contatos de TB, pessoas com sintomas respiratórios que sugerem TB, pessoas com risco de adoecimento ou na investigação de problemas relacionados a medicamentos, sendo fundamental a participação do farmacêutico nas visitas domiciliares e nas atividades de atendimento às pessoas em situação de rua, como por exemplo, nos consultórios na rua;

3) Encaminhamento interno por outros profissionais de saúde, uma vez que todas as pessoas com TB ou ILTB tem a indicação de ser encaminhadas para avaliação e acompanhamento farmacêutico, seja por meio de consultas (pelo menos três) ou prestação de outros serviços clínicos;
4) Encaminhamento por serviços especializados, quando a pessoa é contra-referenciada por ambulatórios de especialidades, hospitais, laboratórios ou outros pontos de atenção da rede.

A APS deve ser a principal porta de entrada da pessoa com TB ou ILTB no SUS. Ao ser diagnosticada com TB ou ao preencher critério para início do TPT, a pessoa deverá ser acolhida pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS), com início do acompanhamento mensal durante todo o período do tratamento.

Nesse contexto, é indicado o encaminhamento para acompanhamento farmacêutico, conforme item 8.4.4, com agendamento das consultas farmacêuticas. Ressalta-se que o acompanhamento pelo farmacêutico deverá ser realizado independentemente de encaminhamento prévio por outro profissional de saúde.

Nos casos em que a porta de entrada da pessoa com TB sensível ou com ILTB não for a APS, especialmente nas urgências/emergências, o farmacêutico também deve atuar no cuidado e acompanhamento farmacêutico, com abertura de agendamento para consultas.

O profissional prescritor ou a equipe de saúde que realizou o atendimento da pessoa com TB ou ILTB na unidade deve encaminhá-la para a consulta farmacêutica e realizar o primeiro agendamento. Os demais agendamentos serão realizados pelo farmacêutico, conforme disposto no item 8.4.4. O farmacêutico poderá identificar a necessidade de realização da consulta farmacêutica durante a dispensação do medicamento e proceder com o agendamento, mesmo que não tenha sido realizado encaminhamento prévio por outro profissional de saúde.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias (dentre outros), o ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser diverso daquele destinado à dispensação e à circulação de pessoas em geral, devendo o estabelecimento dispor de espaço específico para esse fim. O ambiente para prestação dos serviços que demandam atendimento individualizado deve garantir a privacidade e o conforto dos usuários, possuindo dimensões, mobiliário e infra-estrutura compatíveis com as atividades e serviços a serem oferecidos. Portanto, as unidades devem disponibilizar de consultório para realização da consulta farmacêutica.

8.2. Cuidado Farmacêutico

As etapas do cuidado farmacêutico à pessoa com TB e à pessoa com ILTB podem ser encontradas nos apêndices 1 e 2, respectivamente, assim como o fluxo do cuidado farmacêutico à pessoa com TB sensível e da pessoa com ILTB, que estão nos apêndices 3 e 4, respectivamente. Os serviços descritos a seguir compõem a Carteira de Serviços do Cuidado Farmacêutico da SES-DF (Distrito Federal, 2025).

8.3. Conduta Preventiva

As principais ações a serem desenvolvidas com o intuito de garantir a prevenção e o agravamento da TB serão aquelas voltadas à interrupção da cadeia de transmissão da doença no âmbito da saúde pública.

O farmacêutico deve atuar na educação em saúde; rastreamento em saúde; identificação precoce de casos com suspeita de TB; tratamento adequado dos casos confirmados de TB; oferta da vacina BCG; identificação da ILTB e do TPT; avaliação e tratamento de comorbidades; e promoção da adesão ao tratamento.

8.3.1 Educação em saúde

As ações de educação em saúde na conduta preventiva compreendem:

- Conscientização da população sobre a doença (sinais e sintomas), formas de transmissão e importância do tratamento;
- Orientações para mitigação do preconceito e do estigma associados à doença; e
- Estímulo à vacinação da BCG para crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

8.3.2 Rastreamento em saúde

As ações de rastreamento em saúde na conduta preventiva compreendem:

- Identificação precoce de casos com suspeita de TB por meio de busca ativa;
- Investigação e acompanhamento de pessoas que tiveram contato com outras pessoas com TB ativa ou que convivam com elas, principalmente as que possuam critérios de vulnerabilidade (ex.: imunossuprimidos, crianças e idosos); e
- Prescrição e início do TPT, estratégia crucial para prevenir o desenvolvimento da TB ativa.

Destaca-se que a investigação de contatos no âmbito do cuidado farmacêutico inclui a aplicação e leitura da PT pelo farmacêutico capacitado, conforme normativas do Conselho Regional de Farmácia do DF.

Adicionalmente, as ações voltadas ao controle de infecção também têm como objetivo a prevenção, especialmente dos trabalhadores da saúde. A atuação do farmacêutico deve considerar essas medidas como parte integrante do cuidado, reforçando-as durante os atendimentos e acompanhamentos clínicos. O controle eficaz da infecção contribui não apenas para a proteção individual, mas também para a saúde coletiva e para a interrupção da cadeia de transmissão. Dentre essas medidas destacam-se (Brasil, 2023):

- Administrativas ou gerenciais:
    - Consideram-se todas as medidas que impedem a geração de partículas infectantes.
    - O farmacêutico deve, entre outras atividades:

        - Implementar protocolos de atendimento na unidade de saúde;
        - Estar apto a identificar, precocemente, sinais e sintomas de TB e realizar, também, busca ativa de casos na unidade de saúde;
        - Realizar a provisão de quantitativo de insumos e medicamentos, sob sua responsabilidade, para evitar ruptura de estoques e atraso no início do tratamento.
- De controle ambiental ou de engenharia:
    - Todas as atividades que evitam a propagação e a acumulação de partículas infectantes.
    - O farmacêutico, durante o acolhimento ou atendimento, deve:
        - Orientar sobre a importância de manter ambientes bem ventilados, tanto em casa quanto nos serviços de saúde.
- Medidas de proteção respiratória individual:
    - Previnem a inalação de partículas infectantes, inclui o uso adequado de máscaras.
    - O farmaceutico deve:
        - Orientar à pessoa com TB bacilífera que use máscara cirúrgica, especialmente no início do tratamento;
        - Uso de máscaras N95/PFF2 deve ser feita pelos profissionais de saúde, quando estiverem em ambientes fechados e com risco aumentado de exposição.

8.4. Conduta Geral

A atuação clínica do farmacêutico nesse processo encontra respaldo na legislação brasileira, incluindo a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, que reconhece a farmácia como estabelecimento de saúde e estabelece as atribuições clínicas do farmacêutico, bem como nas Resoluções do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 585/2013 e nº 586/2013, que regulamentam as atribuições clínicas do farmacêutico e a prescrição farmacêutica no âmbito de protocolos, diretrizes clínicas e programas de saúde pública.

8.4.1 Anamnese farmacêutica

Nesse momento é possível coletar as principais informações que serão úteis para avaliar as possíveis dificuldades que impactam a adesão ao tratamento e potenciais interações medicamentosas entre os medicamentos de uso prévio do paciente e os medicamentos envolvidos no tratamento da TB e da ILTB. As interações medicamentosas podem ser identificadas no MedSUS, no Manual de Recomendações e Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019) e nas bulas dos medicamentos.

Por meio de entrevista estruturada, que tem por objetivo o registro correto dos dados pessoais, clínicos e sociais importantes para o correto manejo da pessoa com TB ou ILTB, o farmacêutico deve coletar dados da pessoa, conforme formulário apresentado no apêndice 6.

8.4.2 Análise técnica da prescrição

Nessa etapa, o farmacêutico realizará a revisão dos itens obrigatórios da prescrição medicamentosa para a TB ou ILTB.

Conforme a RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, os medicamentos da TB e ILTB são classificados como antimicrobianos. Dessa forma, a prescrição deve ser realizada em 2 (duas) vias, em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde.

O art. 9º da referida RDC estabelece que, em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada por até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão. Entretanto, o §2º do mesmo artigo prevê que, nos casos de tratamentos vinculados a programas do MS, que exijam períodos diferentes desse prazo, a prescrição e a dispensação deverão seguir as diretrizes específicas desses programas.

Considerando que a TB constitui um problema de saúde pública e integra programa específico do MS, os prazos e as condições de prescrição e dispensação dos medicamentos para TB e ILTB devem observar as recomendações estabelecidas nas diretrizes nacionais para o controle da TB. Destaca-se que os enfermeiros também são autorizados a prescrever tanto o tratamento da TB quanto da ILTB.

Além da verificação dos itens obrigatórios previstos na RDC nº 471/2021, a análise técnica da prescrição deve incluir a avaliação crítica dos seguintes aspectos:

1) Aprazamento e regularidade da administração;
2) Associações e adequação dos esquemas de tratamento;
3) Interações medicamentosas relevantes;
4) Dose e forma farmacêutica;
5) Segurança e duplicidade terapêutica;
6) Acessibilidade e disponibilidade dos medicamentos.

8.4.3 Revisão da farmacoterapia

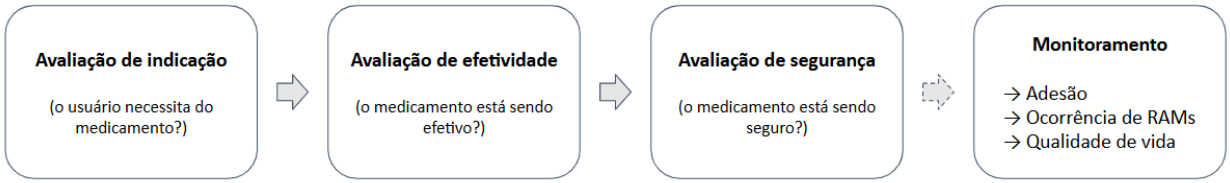
A revisão da farmacoterapia é um serviço que será realizado pelo farmacêutico com intuito de avaliar criticamente os medicamentos utilizados pela pessoa, com os objetivos de otimizar a farmacoterapia, minimizar o risco de ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos (PRMs), promover a adesão ao tratamento e os resultados terapêuticos.

De acordo com a Carteira de Serviços do Cuidado Farmacêutico da SES-DF (Distrito Federal, 2025), a anamnese farmacêutica (8.4.1) e a análise técnica da prescrição (8.4.2) são pré-requisitos

para execução da revisão da farmacoterapia. Nessa etapa, os dados coletados durante a análise técnica da prescrição e a anamnese farmacêutica subsidiarão as atividades a serem executadas.

O modelo conceitual consiste em verificar a indicação, efetividade, segurança de cada medicamento, corroborada pela avaliação da adesão por parte do usuário/paciente, ocorrência de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) e monitoramento de qualidade de vida (figura 1).

Figura 1. Raciocínio clínico para resolução dos problemas relacionados a medicamentos.



Fonte: Diretoria de Assistência Farmacêutica- DIASF/SULOG/SEGEA/SES-DF.

8.4.3.1 Avaliação da indicação

A avaliação da indicação de uso de medicamentos é uma etapa fundamental da revisão da farmacoterapia no âmbito do cuidado farmacêutico. Essa etapa tem como objetivo verificar se existe uma justificativa clínica adequada para o uso de um determinado fármaco, assegurando que a farmacoterapia esteja alinhada ao diagnóstico, às necessidades de saúde da pessoa e às recomendações vigentes.

No contexto da TB e da ILTB, essa avaliação envolve a confirmação de que há diagnóstico ou condição clínica que justifique a prescrição de medicamentos indicados, bem como a análise da adequação do esquema terapêutico selecionado em relação às diretrizes clínicas vigentes, a existência de alternativas terapêuticas mais apropriadas e a adequação do tratamento às características individuais e preferências da pessoa.

Essa atividade integra o processo de cuidado farmacêutico e está fundamentada no método clínico farmacêutico, que orienta a identificação, prevenção e resolução de PRMs, conforme descrito pelo MS e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Brasil, 2020b).

A seguir, seguem 4 (quatro) perguntas norteadoras e possíveis intervenções:

1) O esquema de tratamento e medicamento(s) estão indicados corretamente?

No caso do tratamento para TB é fundamental observar se a pessoa possui diagnóstico laboratorial ou quadro clínico-epidemiológico que justifique iniciar o tratamento proposto.

No caso de ILTB, é importante também observar se houve exclusão da possibilidade de TB ativa para início do tratamento.

2) ***A prescrição está alinhada às recomendações do MS?***

Os esquemas de tratamento da TB e ILTB e suas indicações são definidos em diretrizes do MS (Brasil, 2019; Brasil, 2020; Brasil, 2024) e podem ser encontrados no item 8.5.2 deste protocolo.

3) ***O esquema de tratamento é adequado ao perfil da pessoa (idade, comorbidades, alergias, gravidez/lactação, entre outros)?***

No caso de TB pediátrica, deve-se verificar se o esquema de tratamento proposto está adequado e se a posologia está de acordo com o peso e idade da pessoa. Também deve-se verificar se, em caso de crianças, o medicamento prescrito foi o comprimido dispersível, disponível para o tratamento da TB pediátrica.

Para os tratamentos de ILTB é imprescindível a avaliação criteriosa quanto à indicação, conforme Nota Informativa nº 15/2024-CGTM/DATHI/SVSA/MS. As pessoas que apresentam maior vulnerabilidade ao desenvolvimento da doença após o contato com caso diagnosticado de TB pulmonar: crianças menores de 10 anos de idade; recém-nascidos coabitantes de caso fonte; pessoa vivendo com HIV ou aids; e pessoas que farão uso ou estão em uso de imunobiológicos e/ou imunossupressores.

Em caso de identificação de inconsistências ou erros na prescrição relacionados ao TPT, o farmacêutico poderá realizar ajustes na prescrição, quando cabível, no âmbito de suas atribuições clínicas e em conformidade com as diretrizes do MS (Brasil, 2024), que respaldam a prescrição farmacêutica no TPT.

Esses ajustes podem incluir correção de dose conforme peso corporal, adequação do intervalo posológico, ajuste da duração do tratamento conforme o esquema terapêutico recomendado, entre outros.

Nos casos de prescrição relacionados ao tratamento da TB, eventuais inconsistências ou necessidades de ajuste devem ser comunicadas ao profissional prescritor responsável, para avaliação e correção da prescrição, mantendo a articulação com a equipe assistencial.

4) ***A duração proposta do tratamento é apropriada?***

Os quadros de 4 a 7 apresentam o tempo de tratamento de cada esquema terapêutico para TB e ILTB. Existem alguns casos em que o esquema de tratamento da TB pode ser maior que o estabelecido, conforme exemplificado no item 8.5.3 deste protocolo.

8.4.3.2 Avaliação de efetividade

A avaliação da efetividade dos medicamentos faz parte da revisão da farmacoterapia no contexto do cuidado farmacêutico. Essa etapa tem como objetivo verificar se o tratamento está

produzindo os resultados terapêuticos esperados, orientar possíveis ajustes de dose, verificar intolerâncias ou encaminhamento para outros serviços, conforme o documento “Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF” (Distrito Federal, 2026).

No contexto da TB e da ILTB, essa avaliação envolve o monitoramento sistemático da resposta ao tratamento, por meio da observação da evolução clínica, da presença ou ausência de sinais e sintomas compatíveis com a doença, da análise de exames laboratoriais e de outros indicadores utilizados para acompanhamento terapêutico.

Para os casos de TB ativa, a efetividade do tratamento é avaliada considerando a evolução clínica da pessoa, o monitoramento de sintomas respiratórios e sistêmicos, bem como os resultados de exames laboratoriais e de imagem utilizados no acompanhamento da doença, conforme as recomendações das diretrizes nacionais para o controle da TB.

Nos casos de ILTB, em que o objetivo do tratamento é prevenir a progressão para a forma ativa da doença, a avaliação da efetividade está relacionada principalmente ao monitoramento da adesão ao tratamento, à regularidade da tomada dos medicamentos e à ausência de sinais e sintomas sugestivos de TB ativa durante o período de acompanhamento.

A avaliação da efetividade permite identificar precocemente situações que possam comprometer os resultados terapêuticos, como dificuldades de adesão, posologia inadequada, intolerância medicamentosa ou possíveis interações medicamentosas, possibilitando a adoção de intervenções oportunas, incluindo orientações ao usuário, ajustes na farmacoterapia quando cabíveis no âmbito dos protocolos estabelecidos ou encaminhamento para avaliação por outros profissionais da equipe de saúde ou serviços de referência, conforme o documento “Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF” (Distrito Federal, 2026).

Essa atividade integra o processo de cuidado farmacêutico e está fundamentada no método clínico farmacêutico, que orienta a identificação, prevenção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos (Brasil, 2020b).

Com base nessa avaliação, o farmacêutico poderá identificar necessidades de intervenção e adotar as condutas pertinentes no âmbito de sua atuação profissional e dos protocolos institucionais vigentes. Em apoio a esse processo, seguem perguntas norteadoras e possíveis intervenções a serem consideradas na avaliação da efetividade da farmacoterapia:

1) ***O(s) medicamento(s) está(ão) produzindo a resposta terapêutica esperada?***

A efetividade do tratamento da TB pulmonar é avaliada por meio do exame laboratorial de baciloscopia, solicitado mensalmente. Ao final da segunda semana de tratamento, espera-se que a pessoa em tratamento já não tenha mais baciloscopia positiva, porém, algumas pessoas podem

persistir com resultado positivo sem que seja uma falha terapêutica.

Esses casos precisam ser avaliados quanto à adesão, armazenamento correto dos medicamentos, horário de tomada, possibilidade de intolerância a algum dos medicamentos do esquema básico, possibilidade de resistência aos fármacos e presença de comorbidades associadas que dificultem a resposta ao tratamento (por exemplo: diabetes).

Destaca-se que etilismo, tabagismo ou uso de substâncias psicoativas, além de outros determinantes e/ou condicionantes sociais, podem influenciar negativamente a adesão ao tratamento.

2) ***Há sinais clínicos ou resultados de baciloscopias que apoiem a efetividade do tratamento?***

Considera-se evolução favorável da TB quando a pessoa adere ao tratamento e apresenta melhora clínica, associada à negativação da baciloscopia e à melhora do aspecto radiológico.

Já a evolução desfavorável é quando um dos três componentes citados anteriormente não estão presentes, ou seja, a ausência de melhora clínica, a persistência de baciloscopia positiva e aspecto radiológico evidenciando atividade de doença.

Se houver sinais e sintomas de TB presentes, deve-se verificar se é piora clínica do quadro de TB (por exemplo, por falência ao tratamento ou má adesão ao tratamento) ou ativação da TB em pessoa inicialmente com ILTB. Se for identificado um caso de TB extrapulmonar, deve-se informar à equipe de saúde para realizar o correto encaminhamento da pessoa para o serviço especializado no atendimento desses casos, se necessário, conforme o documento "Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF" (Distrito Federal, 2026).

3) ***O esquema posológico (dose, frequência, via de administração) está adequado para alcançar a efetividade?***

É importante observar se a posologia está adequada ao peso da pessoa e se o tempo de tratamento prescrito está adequado, considerando o regime terapêutico adotado associado aos fatores intrínsecos e extrínsecos para ocorrência de eventos adversos e para uma boa adesão ao plano terapêutico instituído.

4) ***Existe necessidade de ajuste da dose/posologia com base em parâmetros clínicos, peso, função renal ou hepática?***

Os exames adicionais têm a seguinte função:

- Hemograma: auxilia na identificação de efeitos adversos e avaliação da condição de saúde;
- Função Hepática: solicitada no início do tratamento para verificar a necessidade de mudança para esquema especial e durante o tratamento quando houver suspeita de hepatopatias associadas ou reações adversas;
- Função Renal: solicitada no início do tratamento para verificar a necessidade de mudança

para esquema especial de tratamento e durante o tratamento quando houver suspeita de doença renal associada (especialmente em idosos);

- Hemoglobina Glicada: utilizada para orientar o ajuste de dose, a meta glicêmica ideal é HbA1c ≤ 7,0%;
- Glicemia de Jejum: solicitada ao início do tratamento para orientar o ajuste de dose, a meta glicêmica ideal é glicemia de jejum entre 70 e 130 mg/dL e pós-prandial abaixo de 180 mg/dL.

Em caso de identificação de necessidade de ajuste da dose e posologia do TPT, o farmacêutico poderá realizar ajustes na prescrição, quando cabível, no âmbito de suas atribuições clínicas e em conformidade com as diretrizes do MS (Brasil, 2024), que respaldam a prescrição farmacêutica no TPT.

Nos casos de prescrição relacionados ao tratamento da TB, eventuais ajustes devem ser comunicados ao profissional prescritor responsável, para avaliação e correção da prescrição, mantendo a articulação com a equipe assistencial.

Em caso de identificação de erros, o farmacêutico pode realizar ajuste em prescrição prévia para ILTB. No caso de prescrição para tratamento da TB, o farmacêutico deve informar ao prescritor para correção.

5) Há interações medicamentosas (com outros medicamentos, alimentos, etc.) ou fatores que possam comprometer a efetividade do tratamento?

Em resumo, as interações medicamentosas relacionadas aos medicamentos utilizados para o tratamento da TB e da ILTB podem ocorrer durante a absorção ou durante o metabolismo do fármaco. Por isso é importante orientar que outros fármacos ou até alimentos que aumentem o pH gástrico podem interferir na absorção da rifampicina, isoniazida e etambutol. Já a rifampicina, por ser indutor enzimático, possui interações com muitos outros medicamentos e ainda possui interação com contraceptivos orais.

Assim, é importante observar possíveis efeitos adversos relacionados ao início da terapia (item 8.4.12 deste protocolo) e os critérios para indicação de suspensão do tratamento (item 8.5.3 deste protocolo). Ainda, se for identificada dificuldades com leitura e/ou interpretação da prescrição, deve-se realizar ações voltadas à melhoria da adesão ao tratamento junto à pessoa. Se forem identificadas queixas que podem sugerir reações adversas ou intolerância medicamentosa, realizar o correto manejo conforme item 8.4.12 deste protocolo e demais informações constantes no MedSUS, no Manual de Recomendações e Controle da Tuberculose no Brasil e nas bulas dos medicamentos.

Em pessoas com TB-HIV, deve-se atentar para as interações medicamentosas entre os fármacos da TB e os antirretrovirais (ARV), caso haja uma possível interação que cause impacto em algum dos

tratamentos, é importante informar aos demais membros da equipe de saúde para realizar o correto encaminhamento da pessoa à unidade onde ela costuma fazer acompanhamento do tratamento do HIV para possíveis ajustes no tratamento. Cabe ressaltar ainda que, nessa população, dependendo do grau de imunossupressão, podem ocorrer efeitos adversos maiores ao tratamento da TB.

Na população com diabetes mellitus, deve-se orientar sobre a importância do controle glicêmico adequado, uma vez que, a doença descompensada pode prejudicar a resposta ao tratamento da TB e resultar em prolongamento do tratamento e predisposição a recidivas, em alguns casos pode ser necessário ainda o ajuste no tratamento em curso para diabetes já que os fármacos de primeira linha para TB podem impactar no metabolismo glicêmico.

8.4.3.3 Avaliação de segurança

A avaliação da segurança na farmacoterapia tem como finalidade identificar, prevenir e manejar possíveis reações adversas, interações medicamentosas e outros problemas relacionados ao uso de medicamentos que possam comprometer a saúde e o bem-estar da pessoa.

Essa análise requer a detecção de sinais clínicos, sintomas inesperados, alterações laboratoriais e histórico prévio de eventos adversos, além da revisão do perfil de risco da pessoa, incluindo comorbidades, idade, gestação, função hepática e renal. A identificação precoce de eventos de insegurança permite a implementação de estratégias de mitigação de risco, como o ajuste de dose, inclusão de outros medicamentos para redução de efeitos adversos esperados troca de medicamento ou adoção de medidas de monitoramento intensivo. Assim, a avaliação da segurança é indispensável para promover o uso seguro dos medicamentos, prevenir danos evitáveis e apoiar decisões clínicas baseadas na relação risco-benefício individualizada.

É de suma importância que condições de saúde como coinfecção TB-HIV, presença de hepatopatia, nefropatia e diabetes mellitus sejam identificadas e consideradas diante do planejamento terapêutico da pessoa.

Seguem 5 (cinco) perguntas norteadoras e possíveis intervenções:

1) ***Há relatos de reações adversas associadas ao uso do(s) medicamento(s)?***

É importante saber que algumas reações são comuns ao tratamento e, por isso, a orientação é fundamental para garantia da adesão, conforme item 8.4.12. deste protocolo.

2) ***A pessoa apresenta fatores de risco para eventos adversos (idade avançada, função renal/hepática comprometida, polifarmácia)?***

As reações adversas “maiores” ocorrem com menor frequência e a idade (a partir da quarta década); dependência química ao álcool (ingestão diária de álcool > 80g); desnutrição (perda de mais

de 15% do peso corporal); história de doença hepática prévia; e coinfecção pelo vírus HIV, em fase avançada de imunossupressão são fatores de risco para o desenvolvimento de reações adversas.

Em relação a hepatopatias, os medicamentos empregados no tratamento da TB e ILTB muitas vezes podem ocasionar alterações laboratoriais transitórias e de resolução espontânea, entretanto, quando a pessoa apresentar náusea, vômito, icterícia e níveis séricos de TGO e TGP três vezes superior ao valor da normalidade ou com enzimas hepáticas cinco vezes o valor da normalidade, mesmo sem sintomas, o tratamento deve ser interrompido e deve-se informar aos demais membros da equipe de saúde para realizar o correto encaminhamento da pessoa para o serviço especializado no atendimento desses casos, conforme o documento "Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF" (Distrito Federal, 2026).

Em pessoas com nefropatia, é imprescindível o conhecimento dos valores de creatinina e o cálculo da taxa de depuração (clearance) antes de iniciar o esquema terapêutico, uma vez que o esquema necessitará de ajuste de dose e posologia naqueles que possuem clearance menor que 30 mL/min e naqueles que realizam terapia renal substitutiva.

3) ***Há histórico de alergia ou intolerância ao medicamento?***

Em alguns casos, pode ser necessário modificar o esquema de tratamento ou suspender temporariamente o medicamento.

4) ***Existem interações medicamentosas relevantes que aumentem o risco de toxicidade?***

No caso de surgimento de reações adversas menores, não há necessidade de alterar o esquema de tratamento e essas devem ser manejadas no próprio serviço (item 8.4.12. deste protocolo).

No caso de surgimento de reações adversas maiores, a pessoa deve ser avaliada clinicamente para identificar qual ação a ser tomada.

5) ***O medicamento exige monitoramento laboratorial específico (ex: níveis séricos, função hepática, hematológica)?***

Não há recomendação de monitorização terapêutica dos medicamentos utilizados no tratamento da TB e da ILTB, entretanto, é importante destacar a importância da avaliação da função renal e hepática durante o tratamento, conforme destacado na pergunta 4 do item 8.4.3.2.

8.4.4. Consulta farmacêutica

Como forma de contribuir com o cuidado integral pela equipe multiprofissional, recomenda-se a realização de 3 (três) atendimentos à pessoa com TB, preferencialmente (Brasil, 2026):

- Primeiro atendimento: na fase intensiva, até o 15º dia após o início do tratamento;

- Segundo atendimento: na fase de manutenção, no período de mudança do esquema terapêutico (entre o segundo e terceiro mês);
- Terceiro atendimento: ao final do tratamento.

É fundamental considerar questões de vulnerabilidade da pessoa com TB para realização desses atendimentos.

Durante a consulta farmacêutica, o farmacêutico deve verificar no prontuário ou junto à equipe assistencial se a testagem para HIV já foi realizada. Na ausência de registro dessa informação, deve ser oferecida a testagem para HIV, preferencialmente por meio de teste rápido, a todas as pessoas com TB e seus contatos, independentemente da idade (Brasil, 2019).

Também é fundamental verificar se os casos já foram notificados no Sinan e no Sistema de Informação para notificação das pessoas em tratamento de ILTB (IL-TB). Na ausência de registro, o farmacêutico deve realizar a notificação conforme os fluxos estabelecidos.

Ao identificar a presença de efeitos adversos “maiores”, presença de comorbidades de difícil manejo (transplantes, imunodeficiências, infecção pelo HIV, hepatopatias, diabetes descompensados e insuficiência renal crônica), nos casos de falência ao tratamento ou que apresentem qualquer tipo de resistência aos fármacos, a pessoa com TB deve ser encaminhada a unidade de referência na própria região.

Durante a consulta farmacêutica, também é possível realizar o tratamento diretamente observado (TDO). Conforme Nota Informativa nº 20/2023-CGTM/DATHI/SVSA/MS, é considerado TDO se a observação da tomada dos medicamentos ocorrer, preferencialmente, 5 (cinco) vezes por semana ou no mínimo 3 (três) vezes na semana, durante todo o tratamento. Essa tomada deve ser observada por profissional de saúde ou por meio de sua supervisão.

Ao final do tratamento, a pessoa precisa ter cumprido pelo menos 24 doses supervisionadas na fase de ataque e 48 doses supervisionadas na fase de manutenção. Também será considerado TDO quando a observação da tomada do medicamento se der por recursos digitais, tais como vídeo ou imagem síncronos e assíncronos, chamada de voz, ou mensagem de texto que contenha confirmação autorreferida da pessoa com TB sobre a tomada do medicamento. Entende-se tecnologias digitais: aplicativos de celular, mensagens de texto, ligação telefônica, dentre outros. O uso dessas tecnologias deve estar em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), viabilizando a confidencialidade, segurança e consentimento do usuário quanto ao compartilhamento e ao tratamento das informações pessoais, que devem ser utilizadas exclusivamente para o acompanhamento terapêutico.

No **quadro 1** encontra-se esquematizado os objetivos e ações dos farmacêuticos durante os atendimentos realizados.

Quadro 1. Objetivos e atividades executadas durante as consultas farmacêuticas à pessoa com tuberculose.

CONSULTA	OBJETIVOS E AÇÕES DOS FARMACÊUTICOS
Primeiro atendimento	- Avaliar os dados obtidos na anamnese farmacêutica - Avaliar prescrição (dose, interações, posologia) - Identificar fatores de risco para interrupção do tratamento - Orientar sobre o uso correto dos medicamentos, horários, efeitos adversos - Oferecer teste rápido de HIV, conforme disponibilidade - Iniciar plano de cuidado com metas clínicas - Registrar serviço e agendar reavaliação
Segundo atendimento	- Verificar adesão ao tratamento - Avaliar reações adversas ou sinais clínicos de alerta - Avaliar sinais/sintomas de toxicidade ou falha terapêutica - Avaliar baciloscopia mensal, resultado da cultura e exames laboratoriais (função hepática, renal, etc.) - Reforçar orientações e esclarecer dúvidas - Confirmar se o teste de HIV foi realizado (caso não feito na 1ª consulta) - Atualizar plano de cuidado e registrar intervenções
Terceiro atendimento	- Avaliar desfecho clínico e laboratorial - Verificar conclusão de doses e/ou negativação da baciloscopia - Reforçar orientações sobre sintomas de retorno, autocuidado e vigilância - Orientar sobre acesso à rede e sinais de reativação - Registrar alta farmacêutica

Fonte: autoria própria.

Já para os casos de ILTB, recomenda-se a realização de 3 (três) atendimentos à pessoa com ILTB, preferencialmente:

- Primeiro atendimento: no início do tratamento;
- Segundo atendimento: no meio do tratamento;
- Terceiro atendimento: ao final do tratamento.

Para esquemas de curta duração (ex.: 3HP), as consultas podem ser mais próximas ou reduzidas para duas, se houver acompanhamento intensivo por outro profissional da equipe.

No **quadro 2** encontra-se esquematizado os objetivos e ações dos farmacêuticos durante os atendimentos realizados.

Quadro 2. Objetivos e atividades executadas durante as consultas farmacêuticas à pessoa com infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

CONSULTA	OBJETIVOS E AÇÕES DOS FARMACÊUTICOS
Primeiro atendimento	- Avaliar os dados obtidos na anamnese e avaliar critérios para TPT - Avaliar a necessidade de prescrição de medicamentos - Orientar sobre o esquema de tratamento (duração, intervalo) - Explicar importância da adesão e riscos da progressão da doença - Solicitar ou avaliar exames laboratoriais prévios (se necessário) - Registrar serviço
Segundo atendimento	- Avaliar sintomas e possíveis reações adversas - Verificar adesão ao TPT - Avaliar sinais/sintomas de toxicidade ou falha - Reforçar orientações de seguimento e sintomas de alerta - Atualizar plano de cuidado e registrar
Terceiro atendimento	- Verificar conclusão do esquema (número de doses) - Avaliar sinais/sintomas de toxicidade ou falha - Reforçar vigilância de sintomas e orientação familiar - Registrar desfecho do TPT e realizar alta farmacêutica

Fonte: autoria própria.

8.4.5. Acompanhamento farmacêutico

De acordo com o MS (Brasil, 2019), o acompanhamento da evolução clínica dos casos de TB consiste primordialmente nas seguintes atividades: atendimentos clínicos para todos os casos; controle bacteriológico para os casos pulmonares; e controle radiológico, principalmente quando o exame de imagem tiver sido utilizado como parâmetro auxiliar para o diagnóstico.

De acordo com a Carteira de Serviços a revisão da farmacoterapia (8.4.3) é considerada pré-requisito para execução desse serviço, pois dá subsídios para o acompanhamento.

As pessoas com TB ou ILTB deverão ser acompanhadas para observação da evolução clínica dos sintomas e ocorrência de efeitos adversos ou intolerância que possam resultar em redução da adesão ao tratamento. É importante que a todas as pessoas com TB seja oferecido o TDO.

Ainda, durante o acompanhamento farmacêutico, deve ser verificado o peso corporal atual da pessoa em tratamento para avaliação da necessidade de ajuste da dose dos medicamentos utilizados, e quando disponíveis, a avaliação de exames de função hepática, função renal e glicemia em jejum.

O controle de eficácia do tratamento, do ponto de vista infeccioso, deve ser realizado mensalmente a partir da baciloscopia, sendo que o TRM-TB não possui indicação de uso para avaliação de tratamento,

avaliação de sinais e sintomas e piora da imagem radiológica.

As pessoas que apresentam baciloscopia positiva (poucos bacilos) no quinto ou sexto mês de tratamento, isoladamente, com boa evolução clínica e radiológica devem ser investigadas quanto à adesão, falha de tratamento ou possibilidade de resistência ao tratamento.

As pessoas em acompanhamento do tratamento para ILTB deverão ser acompanhadas para avaliação quanto à adesão ao tratamento, que será mensurada de acordo com o número de doses utilizadas pelo tempo transcorrido.

8.4.6. Prevenção e identificação de erros de medicação

A prevenção de erros de medicação é um dos pilares da segurança do paciente e deve estar integrada ao cuidado farmacêutico prestado às pessoas com TB e ILTB.

Os esquemas terapêuticos utilizados no tratamento da TB e ILTB envolvem múltiplos medicamentos, posologias diferenciadas e durações variáveis, o que aumenta o risco de erros de prescrição, dispensação, administração e acompanhamento. Além disso, há a possibilidade de interações medicamentosas relevantes, especialmente em pessoas vivendo com HIV ou aids, com doenças crônicas ou em uso de outros tratamentos de longa duração.

O farmacêutico, inserido na equipe multiprofissional, atua de forma decisiva na identificação e prevenção desses erros, desenvolvendo serviços e atividades paralelas, tais como:

- Análise técnica da prescrição, garantindo a escolha correta do esquema terapêutico, dose, frequência, duração e vias de administração;
- Orientação individualizada ao paciente e familiares, reforçando a importância do uso correto dos medicamentos, horários, possíveis efeitos adversos e condutas em caso de esquecimento de doses;
- Acompanhamento da adesão terapêutica, identificando barreiras ao uso adequado e propondo soluções para facilitar a rotina do tratamento;
- Monitoramento de eventos adversos e interações medicamentosas, com registro e comunicação à equipe assistencial e aos sistemas de farmacovigilância;
- Uso de instrumentos padronizados de registro e acompanhamento, que permitam identificar precocemente discrepâncias entre prescrição, dispensação e uso dos medicamentos;
- Educação permanente da equipe de saúde, com capacitações e discussões de casos, visando reduzir falhas no processo de cuidado.

Com essas ações, o farmacêutico contribui para a redução de falhas e riscos, assegurando que o tratamento seja realizado de forma eficaz, segura e contínua, o que impacta diretamente na cura da TB, no

sucesso da profilaxia da ILTB e na proteção da saúde pública.

8.4.7. Prescrição farmacêutica

O MS atribui a prescrição do tratamento da TB apenas aos profissionais médicos. Entretanto, conforme Nota Informativa nº 15/2024-CGTM/DATHI/SVSA/MS, os farmacêuticos poderão realizar a prescrição de medicamentos utilizados no TPT, assim como estão autorizados a realizar ajuste da prescrição, alterando o esquema de tratamento, posologia e duração de tratamento, respeitando os esquemas estabelecidos pelo MS e dispostos no item 8.5 deste protocolo.

De acordo com a Carteira de Serviços, a consulta farmacêutica (8.4.4) é considerada pré-requisito para execução desse serviço, pois dá subsídios para a correta prescrição.

Assim, a pessoa com ILTB ou suspeita de ILTB terá acesso aos serviços farmacêuticos de prescrição e solicitação de exames, especialmente quando o profissional de saúde estiver realizando a busca ativa de contatos próximos.

Outras situações de acesso ao serviço de prescrição farmacêutica poderão ocorrer, de acordo com o identificado pelo farmacêutico.

8.4.8. Dispensação

De acordo com a Carteira de Serviços (Distrito Federal, 2025), a análise técnica da prescrição (item 8.4.2) é considerado um pré-requisito para realização da dispensação qualificada.

Além da análise, é importante que o farmacêutico realize:

1) A orientação sobre uso correto dos medicamentos, explicando como tomar cada um deles, em que horário, se deve ser em jejum ou não e o que fazer em caso de esquecimento.
2) A explicação sobre possíveis efeitos adversos, sinais comuns (náusea, urina avermelhada pela rifampicina, alterações na visão por etambutol e etc.) e sinais de alerta que exigem retorno imediato.
3) O reforço da importância da adesão, mostrando que o abandono ou uso irregular pode levar à resistência e piorar a doença.
4) A identificação de interações medicamentosas, especialmente com antirretrovirais, anticonvulsivantes e outros medicamentos de uso contínuo.

Assim, para uma dispensação qualificada, o registro em prontuário também é fundamental, devendo ser anotado todas as orientações, reações adversas relatadas e condutas tomadas durante a realização desse serviço.

8.4.9. Orientações Farmacêutica de alta

De acordo com a Carteira de Serviços (Distrito Federal, 2025), a revisão da farmacoterapia (8.4.3) é considerada pré-requisito para execução desse serviço, pois dá subsídios para a correta orientação farmacêutica de alta.

Considera-se como alta do paciente de TB quando o tratamento for concluído dentro de pelo menos 6 meses, acompanhado da melhora clínica e resolução dos sintomas e pelo menos duas baciloscopias negativas ao longo da fase de manutenção do tratamento (uma no decorrer do tratamento e outra ao final, podendo ser no 5º ou 6º mês).

A interrupção do tratamento da TB se dá quando a pessoa deixa de comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias consecutivos, após a data prevista para o seu retorno. Nos casos de TDO, o prazo de 30 dias é contado a partir da última tomada do medicamento.

Já nos casos de TPT, é considerado como conclusão do tratamento quando a pessoa comprovadamente tomou todas as doses no tempo estabelecido, conforme tópico 8.5.2. No TPT, de acordo com os esquemas apresentados no **quadro 7**, é considerado interrupção do tratamento (abandono) quando:

- Esquema “4R” – ficou 2 meses sem o medicamento, consecutivos ou não;
- Esquema “6H/9H” - ficou 3 meses sem o medicamento, consecutivos ou não;
- Esquema “3HP” - perda de 3 doses, consecutivas ou não.

A pessoa que concluiu o tratamento da TB ou da ILTB deverá ser orientada quanto à suspensão da tomada dos medicamentos, juntamente às devidas orientações relacionadas ao acompanhamento dos sinais e sintomas, uma vez que em caso de retorno de qualquer sintoma, a pessoa deverá buscar a unidade de saúde.

É importante ainda orientar quanto à possibilidade de surgimento de alguns efeitos adversos “tardios”, mesmo posterior à conclusão do tratamento, tais como hepatotoxicidade, neuropatia periférica e neurite óptica.

Quando se tratar de pessoa com diabetes, é importante orientar quanto ao monitoramento glicêmico posterior ao tratamento e possível necessidade de ajuste de dose dos medicamentos em uso.

8.4.10. Gestão da Condição de Saúde

Na gestão da condição de saúde de pessoas com TB ou ILTB, no âmbito da APS, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) constitui uma ferramenta essencial para a organização do cuidado centrado na pessoa. Sua construção exige o envolvimento ativo da equipe multiprofissional, com destaque para o papel do farmacêutico como articulador clínico e gestor do uso racional de medicamentos. De acordo com a Carteira de Serviços (Distrito Federal, 2025), a revisão da farmacoterapia (8.4.3) é considerada pré-requisito para

execução desse serviço, pois dá subsídios técnicos para sua correta execução.

Etapas para a construção do PTS:

1) Diagnóstico situacional da pessoa com TB ou ILTB: nesta etapa, o farmacêutico contribui com a identificação de necessidades clínicas e terapêuticas, histórico de uso de medicamentos, possíveis reações adversas, barreiras à adesão e grau de compreensão do tratamento. Em conjunto com a equipe, são levantadas as vulnerabilidades sociais, econômicas e de saúde, bem como os recursos disponíveis e as intervenções prévias realizadas.

2) Definição de metas de cuidado: a equipe define objetivos terapêuticos alinhados à autonomia da pessoa, ao fortalecimento de sua rede de apoio e à melhoria de sua qualidade de vida. O farmacêutico pode propor metas relacionadas ao uso correto dos medicamentos, à redução de efeitos adversos e ao fortalecimento do autocuidado, com prazos e estratégias acordadas com a pessoa. Nessa etapa é importante definir demais atores e setores que possam ser envolvidos no processo, tais como o serviço social e etc.

3) Divisão de responsabilidades: um profissional de referência é definido para coordenar o plano. O farmacêutico pode assumir o papel de referência clínica farmacêutica, sendo responsável pelo acompanhamento terapêutico e apoio à equipe no monitoramento da resposta ao tratamento, adesão, ajustes posológicos e segurança do paciente.

4) Reavaliação do plano terapêutico: a reavaliação é conduzida periodicamente pelo profissional de referência, em encontros com o usuário, familiares e equipe. O farmacêutico participa dessa etapa avaliando a efetividade terapêutica, propondo adequações no regime medicamentoso quando necessário, e identificando fatores que possam interferir na continuidade do tratamento.

Para garantir a efetividade do PTS, a equipe multiprofissional deve realizar reuniões periódicas, promovendo um espaço de escuta qualificada, pactuação de condutas e revisão conjunta do plano terapêutico. Nesses encontros, o farmacêutico assume papel ativo na discussão de casos clínicos complexos, no apoio à tomada de decisão baseada em evidências e na promoção da segurança do cuidado medicamentoso.

8.4.11. Educação em saúde

A TB provoca profundas mudanças na vida das pessoas acometidas, afetando dimensões familiares, laborais, sociais e psicológicas. O diagnóstico leva ao isolamento, por vezes da própria pessoa acometida, afastamento do trabalho, restrição de convívio social e sentimentos exacerbados, como medo, culpa e vergonha. Esses impactos são intensificados pelo estigma e discriminação, que

persistem mesmo diante de informações técnicas sobre transmissão e tratamento da TB (Brasil, 2019; Brasil, 2022; Rede Brasileira de Comitês de TB, 2025; Teixeira LM *et. al*, 2023).

A educação em saúde, com orientações claras, mostrou impacto positivo no autocuidado e na adesão ao tratamento (Teixeira LM *et. al*, 2023), assim, o profissional farmacêutico precisa estar envolvido nas ações de educação direcionadas à pessoa com TB, especialmente naquelas que envolvem sensibilização e redução do estigma e discriminação.

Nessa etapa, é fundamental avaliar o conhecimento da pessoa com TB ou ILTB sobre a sua condição de saúde e sobre o seu tratamento medicamentoso, questionando sobre o uso, o horário de administração, a quantidade de comprimidos utilizada em cada administração e se faz associação de algum efeito adverso ao uso de cada medicamento.

Além disso, é fundamental que o profissional farmacêutico atue no(a):

- Acolhimento à pessoa com TB ou ILTB, ressaltando as informações relacionadas ao tratamento, às medidas não farmacológicas, às condições de saúde, ao acesso e armazenamento adequado dos medicamentos;
- Esclarecimento de dúvidas por meio de linguagem adequada, levando em consideração o grau de instrução da pessoa;
- Reforço da importância da continuidade e conclusão do tratamento para interrupção do curso da doença e da cadeia de transmissão e na prevenção de futura reativação da doença;
- Repasse de informações sobre os principais efeitos adversos que são manejáveis e, em caso de efeitos adversos maiores, informar que deve procurar atendimento para o correto encaminhamento;
- Controle adequado das demais condições de saúde que podem impactar no tratamento da TB/ILTB;
- Identificação de fatores socioeconômicos e culturais que possam interferir na continuidade o tratamento; e
- Reforço sobre a importância de informar às pessoas do seu convívio para que seja realizada investigação de contatos.

Estão disponíveis vídeos educacionais sobre estigma, discriminação e determinantes sociais de saúde que impactam no curso da doença e que podem ser acessados pelo link https://www.redebrasileiradecomites.com/videos-sobre-tb.

8.4.12. Prevenção, detecção e notificação de eventos adversos relacionados aos medicamentos

De acordo com a Carteira de Serviços (Distrito Federal, 2025), a revisão da farmacoterapia (8.4.3) é considerada pré-requisito para execução desse serviço, pois dá subsídios para que o farmacêutico avalie e possa prevenir, detectar e notificar eventos adversos.

Algumas reações adversas são comuns e podem ser manejadas no serviço de saúde. As reações adversas mais frequentes ao Esquema Básico da TB são mudança da coloração da urina (ocorre universalmente), intolerância gástrica (40%), alterações cutâneas (20%), icterícia (15%) e dores articulares (4%).

Não há necessidade de alteração da composição do esquema de tratamento na ocorrência de reações adversas menores. No **quadro 8** estão apresentadas as principais reações adversas menores aos medicamentos utilizados no tratamento da TB sensível e no TPT e o manejo sugerido.

Quadro 8. Principais reações adversas menores aos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose sensível e no tratamento preventivo da tuberculose e qual a conduta a ser seguida.

Medicamento	**Principais reações adversas**	**Conduta**
isoniazida	Cefaleia e mudança de comportamento (euforia, insônia, depressão leve, ansiedade e sonolência)	Orientar a pessoa sobre o sintoma e avaliar o uso de analgésico.
isoniazida	Neuropatia periférica	Iniciar o uso de piridoxina 50mg/dia e avaliar a evolução.
isoniazida e rifampicina	Febre	Orientar sobre o sintoma e avaliar o uso de analgésico/antitérmico.
isoniazida e rifampicina	Dor articular	Avaliar o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroidais
rifapentina	Cefaleia	Orientar a pessoa sobre o sintoma e avaliar o uso de analgésico.
isoniazida, rifampicina e rifapentina	Prurido e exantema leve (ou rash cutâneo)	Avaliar o uso de anti-histamínicos
rifampicina e rifapentina	Suor/urina de cor avermelhada	Orientar a pessoa sobre o sintoma.
pirazinamida e etambutol	Hiperuricemia (com ou sem sintomas)	Orientar dieta hipopurínica e avaliar o uso de alopurinol, se necessário.
rifapentina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol	Intolerância digestiva (náusea e vômito) e epigastralgia	Reformular o horário da administração dos medicamentos (duas horas após o café da manhã). Considerar o uso de medicamentos para o tratamento dos sintomas e avaliar a função hepática.

Fonte: MedSUS; Brasil, 2019.

As reações adversas aos medicamentos devem ser notificadas à Anvisa, pelo sistema VigiMed

(http://portal.anvisa.gov.br/vigimed), que é o sistema nacional de notificação de eventos adversos a medicamentos, desenvolvido pela Anvisa em cooperação com o Uppsala Monitoring Centre. Seu foco é a farmacovigilância clínica, possibilitando a coleta de relatos de suspeitas de reações adversas a medicamentos em uso no país, inclusive os utilizados no tratamento da tuberculose e da ILTB (Brasil, 2018).

Além de reações adversas, é fundamental monitorar e acompanhar os casos de intolerância aos medicamentos utilizados no tratamento da TB e realização do teste "droga a droga", quando necessário. Esse teste se trata de uma reintrodução sequencial e supervisionada dos medicamentos utilizados no tratamento da TB, um a um, em pessoas que:

- Tiveram reações adversas graves (ex.: hepatotoxicidade, exantemas, reações anafiláticas);
- Ou têm histórico de intolerância importante ao esquema padrão.

Esse teste tem como objetivo confirmar qual medicamento causou a reação adversa e, assim, permitir a reintrodução segura dos medicamentos não implicados e orientar a substituição ou suspensão definitiva de um ou mais fármacos envolvidos na intolerância. Desta forma, o tratamento da TB pode ser seguido com um esquema terapêutico individualizado que seja mais eficaz e seguro.

O teste droga a droga deve ser realizado e supervisionado pela equipe de saúde e, após o período de suspensão total dos medicamentos e melhora clínica da reação adversa, inicia-se a reintrodução gradual dos medicamentos, geralmente na seguinte ordem, porém, deve-se avaliar a ordem conforme gravidade e tipo de reação: 1º - rifampicina; 2º - isoniazida; 3º - etambutol; 4º - pirazinamida.

Os medicamentos são administrados em doses crescentes, geralmente com intervalo de 24 a 48 horas entre cada fármaco, enquanto a pessoa é monitorada clinicamente e laboratorialmente (função hepática, renal, etc.).

Está indicado para os casos de:

- Hepatite medicamentosa presumida (a mais comum);
- Reações cutâneas graves;
- Reações de hipersensibilidade não específicas;
- Polifarmácia com risco elevado de toxicidade.

No cuidado farmacêutico, o profissional deve apoiar a monitorização clínica e laboratorial durante o processo, registrar sinais de reações adversas ao reintroduzir cada fármaco, realizar educação em saúde para a pessoa sobre sinais de alerta e participar da definição de esquemas alternativos, se algum medicamento for definitivamente contraindicado.

Em caso de necessidade de mudança de esquema terapêutico, a pessoa deve ser encaminhada à referência de TB do DF, conforme o documento "Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF" (Distrito Federal, 2026).

8.4.13. Detecção e notificação de desvio de qualidade de medicamentos

Essa ação integra o processo de farmacovigilância, entendido como um sistema contínuo de monitoramento da segurança de medicamentos, que deve ser implementado em todas as etapas do cuidado em saúde. É também considerada uma atividade essencial para o cuidado farmacêutico (CFF, 2013).

No Brasil, utiliza-se o sistema Notivisa, da Anvisa, para o registro dessas notificações:

- Notivisa: sistema informatizado da Anvisa utilizado para a notificação de eventos adversos, queixas técnicas e incidentes relacionados a produtos e serviços sob vigilância sanitária. Abrange medicamentos, mas também dispositivos médicos, cosméticos, saneantes, entre outros (Brasil, 2006).

Assim, o papel do farmacêutico é essencial, uma vez que ele atua na identificação precoce de suspeitas de eventos adversos e desvios de qualidade; no preenchimento adequado e qualificado das notificações, com informações clínicas e farmacoterapêuticas relevantes; na orientação às equipes de saúde sobre a importância da notificação; e na promoção da cultura de segurança do paciente e do uso racional de medicamentos.

8.5. Tratamento Não Farmacológico

8.5.1. Práticas Integrativas em Saúde

Os saberes populares, construídos historicamente e repassados oralmente, continuam coexistindo com os conhecimentos biomédicos. Muitas pessoas recorrem a práticas tradicionais, como o uso de plantas medicinais, para lidar com sintomas e efeitos colaterais do tratamento da TB e da ILTB, o que está em consonância com os princípios da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Entretanto, as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) precisam ser utilizadas como complementares ao tratamento medicamentoso e nunca como substitutos, uma vez que o tratamento de doenças infecciosas deve ser realizado com medicamentos antimicrobianos adequados para atingimento da cura.

A atuação do farmacêutico em práticas integrativas e complementares é respaldada pelo CFF, conforme estabelecido nas Resoluções CFF nº 733, de 26 de agosto de 2022, e nº 710, de 30 de julho de 2021. A escolha e o uso de PICs devem ser feitas considerando as necessidades individuais de cada pessoa. É fundamental que a pessoa receba orientação adequada sobre as práticas integrativas, incluindo seus benefícios, riscos e limitações. A adesão ao tratamento medicamentoso é essencial para a cura da TB e as PICS podem auxiliar nesse processo, a exemplo do uso da auriculoterapia para manejo de náuseas e vômitos em pessoas em tratamento.

De acordo com a Carteira de Serviços (Distrito Federal, 2025), a consulta farmacêutica (8.4.4) é considerada pré-requisito para execução desse serviço, pois dá subsídios para a correta orientação de práticas integrativas.

8.6. Tratamento Farmacológico

As ações da Assistência Farmacêutica no DF têm por finalidade promover a resolubilidade e a integralidade do cuidado em saúde. Desse modo, o fornecimento de medicamentos é feito para atender as demandas de saúde da população e complementar o tratamento. Esse serviço varia de acordo com a necessidade, podendo ser de atenção básica, média e alta complexidade.

Os medicamentos para o tratamento farmacológico da TB pulmonar e para o TPT são disponibilizados exclusivamente pelo SUS. O acesso ao tratamento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas da SES-DF, Farmácia-Escola do Hospital Universitário (HUB), Cedin e nas unidades hospitalares da SES-DF às pessoas internadas, conforme o **quadro 3**.

Após diagnóstico e acolhimento da pessoa com TB, é importante que seja oferecida a modalidade de TDO, quando se tratar de tratamento ambulatorial.

Após o início do tratamento, a pessoa deve comparecer a consultas mensais para avaliação da adesão ao tratamento, e também às consultas farmacêuticas, conforme item 8.4.4.

Quando se tratar de ILTB o tratamento envolverá esquema diferente do esquema padronizado para o tratamento da TB, conforme **quadro 7**.

As pessoas que farão o tratamento da TB extrapulmonar, da TB drogarresistente ou da TB com esquemas especiais de tratamento (por conta de intolerância ou outros), devem ser encaminhadas a unidades de referência para TB no DF, conforme o documento "Fluxogramas Rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF" (Distrito Federal, 2026).

Fármaco(s)

Quadro 3.: Medicamentos relacionados ao tratamento da tuberculose pulmonar sensível e do tratamento preventivo da tuberculose, conforme Relação de Medicamentos padronizados na SES-DF (REME).

Código	Descrição	Indicação	Farmácia
MSE90146	etambutol (cloridrato) comprimido 400mg	Teste droga a droga para verificação de intolerância e tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Policlínica de Planaltina, Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e HRAN
MSE35942	isoniazida comprimido 300mg - Tuberculose	Medicamentos para o TPT	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN (antigo Hospital Dia) e Policlínica Planaltina
MSE35975	pirazinamida 150 mg comprimido dispersível - Tuberculose	Teste droga a droga para verificação de intolerância e tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE90149	pirazinamida comprimido 500mg - Tuberculose	Teste droga a droga para verificação de intolerância e tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE38351	piridoxina comprimido 50mg - tuberculose	Usado na prevenção e tratamento da neuropatia periférica causada pela isoniazida[1]	Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN (antigo Hospital Dia) e UBS (farmácia ambulatorial) e uso hospitalar

MSE4387	rifabutina cápsula 150 mg - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB em PVHA	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN
MSE22470	rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol 275 mg comprimido - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE90150	rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg comprimido - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE37482	rifampicina 300 mg + isoniazida 150 mg comprimido - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE35977	rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg + pirazinamida 150 mg comprimido dispersível - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE35976	rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg comprimido dispersível - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB e TPT	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE35960	rifampicina cápsula 300mg - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB e TPT	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e HRAN
MSE35963	rifampicina suspensão oral 20mg/mL frasco com doseador - Tuberculose	Medicamentos para o tratamento da TB e TPT	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE37990	rifapentina comprimido 150mg - Tuberculose	Medicamentos para o TPT	UBS (farmácia ambulatorial), Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN e Policlínicas
MSE34500	rifapentina + isoniazida comprimido 300 mg + 300 mg - Tuberculose	Medicamentos para o TPT	UBS (farmácia ambulatorial), HRAN, Farmácia Escola (HUB), Centro Especializado em Doenças Infecciosas - CEDIN (antigo Hospital Dia), Policlínica de Planaltina, Policlínica Ceilândia e Policlínica do Gama

Fonte: Relação de Medicamentos Essenciais - REME - DF 2025.

Legenda: 1- uso de piridoxina para prevenção ou tratamento da neuropatia periférica, conforme recomendações contidas na Nota Informativa nº 16/2014 do Ministério da Saúde.

Esquema de Administração

O esquema de tratamento da TB sensível deve seguir as orientações estabelecidas pelo MS, conforme o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasi, 2019) e demais documentos normativos, conforme descrito no **quadro 4**. O esquema padrão de tratamento é chamado de "Esquema

Básico" e se divide em duas fases, uma intensiva (2 primeiros meses) e uma de manutenção (4 últimos meses).

Quadro 4. Esquema básico de tratamento da tuberculose em adultos, adolescentes e crianças ≥ 10 anos de idade.

Fase	Medicamentos	Peso	Posologia	Nº de comprimidos	Duração do tratamento
Intensiva	Comprimidos em DFC de R 150mg / H 75mg / Z 400mg / E 275mg	20 a 35kg	R 300mg / H 150mg / Z 800mg / E 550mg	2 comprimidos	2 meses (60 dias)
		36 a 50kg	R 450mg / H 225mg / Z 1200mg / E 825mg	3 comprimidos	
		51 a 70kg	R 600mg / H 300mg / Z 1600mg / E 1100mg	4 comprimidos	
		> 70kg	R 750mg / H 375mg / Z 2000mg / E 1375mg	5 comprimidos	
Manutenção	Comprimidos em DFC de R 300mg / H 150mg e Comprimidos em DFC de R 150mg / H 75mg	20 a 35kg	R 300mg / H 150mg	1 comprimido de 300mg / 150mg ***ou*** 2 comprimidos de 150mg / 75mg	4 meses (120 dias)
		36 a 50kg	R 450mg / H 225mg	1 comprimido de 300mg / 150mg + 1 comprimido de 150mg / 75mg ***ou*** 3 comprimidos de 150mg / 75mg	
		51 a 70kg	R 600mg / H 300mg	2 comprimidos de 300mg / 150mg ***ou*** 4 comprimidos de 150mg / 75mg	
		> 70kg	R 750mg / H 375mg	2 comprimidos de 300mg / 150mg + 1 comprimido de 150mg / 75mg ***ou*** 5 comprimidos de 150mg / 75mg	

Legenda: R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; E = etambutol; DFC = dose fixa combinada

Fonte: Brasil, 2019

Já o tratamento de crianças pode ocorrer tanto com o esquema básico (**quadro 5**) quanto com esquemas encurtados (**quadro 6**). O esquema encurtado de tratamento da TB sensível é recomendado exclusivamente para crianças e adolescentes com idade entre 3 meses e 16 anos, com TB sensível e não grave, sem suspeita de TBDR (Brasil, 2024).

Quadro 5. Esquema básico de tratamento em crianças < 10 anos de idade.

Fase	Medicamentos	Peso do paciente	Posologia	Nº de comprimidos	Duração do tratamento
Intensiva	Comprimidos DFC dispersíveis R 75mg / H 50mg / Z 150mg	4 a 7kg	R 75mg / H 50mg / Z 150mg	1 comprimido	2 meses (60 dias)
		8 a 11kg	R 150mg / H 100mg / Z 300mg	2 comprimidos	
		12 a 15kg	R 225mg / H 150mg / Z 450mg	3 comprimidos	
		16 a 24kg	R 300mg / H 200mg / Z 600mg	4 comprimidos	
	RHZ em doses individualizadas[1]	> 25 a 30kg[2]	R 450mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia e Z 900 a 1000 mg/kg/dia	-	
		> 31 a 35kg	R 500mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia e Z 900 a 1000mg/kg/dia	-	
		> 36 a 45kg	R 600mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia e Z 1500mg/kg/dia	-	
		> 45kg	R 600mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia e Z 2000 mg/kg/dia	-	
Manutenção	Comprimidos DFC dispersíveis R 75mg / H 50mg	4 a 7kg	R 75mg / H 50mg	1 comprimido	4 meses (120 dias)
		8 a 11kg	R 150mg / H 100mg	2 comprimidos	
		12 a 15kg	R 225mg / H 150mg	3 comprimidos	
		16 a 24kg	R 300mg / H 200mg	4 comprimidos	
	RH em doses individualizadas[1]	> 25 a 30kg	R 450mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia	-	
		> 31 a 35kg	R 500 mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia	-	
		> 36 a 45kg	R 600mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia	-	
		> 45kg	R 600mg/kg/dia e H 300mg/kg/dia	-	

Legenda: R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; E = etambutol; DFC = dose fixa combinada

1. Doses individualizadas, não é recomendado o uso de DFC nessas faixas de peso. 2. Na faixa de peso de 25 a 35Kg usar os comprimidos dispersíveis de pirazinamida 150mg.

Fonte: Brasil, 2019; Brasil 2020

Quadro 6. Esquema encurtado de tratamento da tuberculose em crianças e adolescentes com idade entre 3 meses e 16 anos, com tuberculose sensível e não grave, sem suspeita de drogarresistência.

Fase	Idade	Medicamentos	Duração do tratamento
Intensiva	3 meses a 10 anos	RHZ[1]	2 meses (60 dias)
	≥ 10 anos a 16 anos	RHZE[2]	
Manutenção	3 meses a 10 anos	RH[1]	2 meses (60 dias)
	≥ 10 anos a 16 anos	RH[2]	

Legenda: R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; E = etambutol; DFC = dose fixa combinada

1. Crianças < 10 anos entre 4kg e 25kg devem utilizar os comprimidos dispersíveis em DFC de RHZ e de RH e com ≥ 25kg devem utilizar RHZ e RH em doses individualizadas.

2. A partir dos 10 anos de idade utilizar os comprimidos RHZE e RH em DFC.

Fonte: Brasil 2024.

Em crianças com idade ≤ 3 meses ou com peso < 4Kg, recomenda-se a rifampicina, isoniazida e pirazinamida em doses individualizadas, sem possibilidade de esquema de curta duração. Para crianças menores de 10 anos com peso igual ou superior a 25Kg, mantém-se a recomendação das doses individualizadas dos medicamentos.

Já para ILTB, ao todo temos disponíveis 5 esquemas de tratamento disponíveis, os quais devem ser recomendados conforme facilidade de adesão da pessoa ao tratamento, relação ao perfil de efeitos adversos dos medicamentos descritos, possibilidade de interações medicamentosas e idade da pessoa, conforme consta no **quadro 7**.

Quadro 7. Esquemas de tratamento preventivo da tuberculose (TPT).

Esquema de tratamento	População	Peso corporal	Medicamento	Posologia	Tempo de tratamento
3HP[1]	Adolescentes > 14 anos e adultos	≥ 30kg	Isoniazida	900mg por semana - dose semanal	12 semanas (12 doses)
			Rifapentina	900mg por semana - dose semanal	
	Crianças e Adolescentes (2 a 14 anos)	10 a 15kg	Isoniazida	300mg por semana - dose semanal	
			Rifapentina	300mg por semana - dose semanal	
		16 a 23kg	Isoniazida	500mg por semana - dose semanal	
			Rifapentina	450mg por semana - dose semanal	
		24 a 30kg	Isoniazida	600mg por semana - dose semanal	
			Rifapentina	600mg por semana - dose semanal	
		> 30kg	Isoniazida	700mg por semana - dose semanal	
			Rifapentina	700mg por semana - dose semanal	
9H	Crianças, adolescentes e adultos	-	Isoniazida	5mg a 10mg/kg de peso até a dose máxima de 300mg por dia	9 meses (270 dias)
6H	Crianças, adolescentes e adultos	-		5mg a 10mg/kg de peso até a dose máxima de 300mg por dia	6 meses (180 dias)
4R[2]	Adultos, adolescentes e crianças ≥ 10 anos	-	Rifampicina	10mg/kg de peso até a dose máxima de 600mg por dia	4 meses (120 dias)
	Crianças < 10 anos	-		15(10-20)mg/kg de peso até a dose máxima de 600mg por dia	4 meses (120 dias)
3RH[3]	Crianças < 10 anos	4 a 7kg	Comprimido DFC dispersível de R 75mg / H 50 mg	R 75mg / H 50mg por dia (1 comprimido)	3 meses (90 dias)
		8 a 11kg		R 150mg / H 100mg por dia (2 comprimidos)	
		12 a 15kg		R 225mg / H 150mg por dia (3 comprimidos)	
		16 a 24kg		R 300mg / H 200mg por dia (4 comprimidos)	

Legenda: R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; E = etambutol; DFC = dose fixa combinada;
1. Esquema 3HP: Contraindicado o uso com inibidores de protease (IP), nevirapina (NVP) e TAF. Pode ser usado com tenofovir, efavirenz, dolutegravir (DLG) e raltegravir (RAL) sem necessidade de ajuste da dose.
2. Esquema 4R: Contraindicada com IP, NVP e TAF. Pode ser usada com DLG e RAL com ajuste da dose.
3. Esquema 3RH: Com comprimidos dispersíveis rifampicina 75mg + isoniazida 50 mg (RH).
Fonte: Brasil, 2024.

Tempo de Tratamento – Critérios de Interrupção

O tempo mínimo de tratamento da TB, no geral, é de 6 meses, podendo ser estendido em alguns casos. Quando a baciloscopia apresentar resultado positivo ao final do segundo mês de tratamento, a **fase de ataque pode ser estendida por mais 30 dias**. Nesse período é importante a equipe de saúde solicitar TRM-TB, para verificar resistência à rifampicina, e TS para verificação de resistência aos demais fármacos.

Em alguns casos individualizados de TB, quando a pessoa apresentar uma evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado na sua segunda fase **(fase de manutenção), por mais 3 (três) meses, somando ao todo 7 (sete) meses**.

A seguir, estão elencadas algumas das principais indicações para a ampliação do tempo de tratamento da fase de manutenção:

a. Pessoas com baciloscopias de acompanhamento negativas, com evolução clínica e/ou radiológica insatisfatórias;
b. Pessoas com baciloscopia positiva (poucos bacilos) no quinto ou sexto mês de tratamento, isoladamente, com boa evolução clínica e radiológica. Nesse caso, precisa solicitar TS para Investigar a possibilidade de TB resistente;
c. Pessoas com apresentação radiológica evidenciando múltiplas cavidades, especialmente se exibem baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento. Nesse caso, precisa solicitar TS para investigar a possibilidade de TB resistente.

Além disso, no esquema encurtado de tratamento da tuberculose em crianças e adolescentes com idade entre 3 meses e 16 anos, com TB sensível e não grave, sem suspeita de TB DR (quadro 6), o tempo total de tratamento da TB é **reduzido de 6 para 4 meses**. Nos casos em que o esquema encurtado não tenha evolução clínica satisfatória, o esquema de 6 meses poderá ser utilizado, ou seja, pode-se estender a fase de manutenção para 4 meses.

Em casos individualizados, como pessoas vivendo com HIV ou pessoas que não apresentem resposta clínica satisfatória ao tratamento padrão, a duração do tratamento poderá ser estendida a critério médico, sendo recomendável que, nesses casos, a pessoa seja encaminhada para o Cedin.

Em caso de baciloscopia positiva ao final do segundo mês, deve-se solicitar a cultura para micobactérias e teste de sensibilidade, devendo a **fase intensiva ser prorrogada por mais 30 dias**.

Se o resultado do TRM-TB e/ou TS acusar resistência a algum fármaco, deve-se comunicar a equipe de saúde para realizar o devido encaminhamento da pessoa ao serviço de acompanhamento adequado. Caso o resultado do TS não tenha sido liberado, deve-se iniciar a fase de manutenção.

As pessoas com evolução insatisfatória (sem melhora clínica ou persistência de baciloscopia associada, ou não, com radiorafia evidenciando atividade de doença) devem também ser encaminhados.

Em caso de necessidade de mudança de esquema terapêutico por conta de reações adversas maiores, o esquema de tratamento deve ser suspenso e a pessoa deve ser encaminhada à referência de TB do DF.

Todos os enamicnhamentos devem ser realizados conforme o documento “Fluxogramas rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF” (Distrito Federal, 2026). Seguem, abaixo, algumas reações adversas consideradas maiores:

- Exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave;
- Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma;
- Neurite óptica;
- Hipoacusia, vertigem e nistagmo;
- Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite;
- Nefrite intersticial;
- Rabdomiólise com mioglobinúria e insuficiência renal.
- Hepatotoxicidade.

Quando se tratar de TPT, o tratamento poderá ser interrompido nas seguintes situações:

- Quando a pessoa apresentar reações adversas maiores, com necessidade de suspensão ou troca do tratamento;
- Quando a pessoa desenvolver a forma ativa da TB durante o tratamento;
- Quando a pessoa apresentar recomendação de tratamento suspensa após desenvolvimento de quadro clínico desfavorável à continuidade do tratamento (ex.: diagnóstico de gravidez no decorrer do tratamento, neste caso o tratamento deverá ser adiado para após o parto).

9. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Principais benefícios esperados:

- Cura clínica e resolução completa dos sintomas
- Prevenção do agravamento da doença e redução das internações hospitalares
- Redução da transmissão da doença
- Redução da mortalidade pela doença
- Prevenção do desenvolvimento de formas resistentes ao esquema de tratamento padrão.

10. MONITORIZAÇÃO

As pessoas deverão ser monitoradas mensalmente para observação da evolução clínica dos sintomas e ocorrência de efeitos adversos ou intolerância que possam resultar em redução da adesão ao tratamento. É importante que a todas as pessoas com TB seja oferecido o TDO.

Sendo recomendável ainda que, durante o monitoramento, seja realizada a pesagem da pessoa para avaliação da necessidade de ajuste da dose dos medicamentos utilizados, e quando disponíveis a avaliação de exames de função hepática, função renal e glicemia em jejum.

Além disso, é fundamental a avaliação da qualidade de vida da pessoa em tratamento, conforme descrito a seguir.

10.1 Avaliação de qualidade de vida

A fim de acompanhar a evolução da qualidade de vida relacionada à saúde em pessoas que recebem atendimento do cuidado farmacêutico, será utilizado o questionário do instrumento EQ-5D-3L (Apêndice 5). Ele contém um sistema descritivo composto de cinco dimensões (5D): mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e ansiedade/depressão. Cada dimensão contém três opções de escolha (3L): sem problemas, problemas moderados e problemas extremos. Também é composto por uma Escala Visual Analógica (VAS), uma linha vertical de 100 mm, que avalia a saúde geral definida entre 0 (pior) e 100 (melhor saúde imaginável). As respostas serão obtidas pelo farmacêutico, que entrevistará a pessoa com auxílio de um formulário eletrônico.

11. ACOMPANHAMENTO PÓS-TRATAMENTO

Ao final do tratamento da TB e da ILTB é fundamental realizar uma consulta farmacêutica de encerramento e orientar sobre prevenção e vigilância de contatos.

11.1. Consulta de encerramento das pessoas que estavam em TPT

A consulta de encerramento deve ser realizada para que se oriente sobre os sinais de TB ativa e a importância de procurar a unidade em caso de sintomas. Àquelas com maior risco de ativação da TB (ex.: HIV, imunossuprimidos), deve-se informar que a equipe de saúde avaliará e elaborará um plano conjunto para vigilância clínica, mesmo após o tratamento.

11.2. Consulta de encerramento das pessoas que estavam em tratamento da TB

A consulta de encerramento tem como objetivo verificar a confirmação da cura clínica e bacteriológica, bem como identificar possíveis sequelas pulmonares decorrentes da doença, conforme estabelecido pelo MS (Brasil, 2019).

Durante essa consulta, o farmacêutico deve verificar em prontuário e junto à equipe assistencial se foram realizados os exames de controle recomendados para o encerramento do caso.

Para os casos pulmonares bacilíferos, deve-se confirmar a realização da coleta de amostra de escarro

para envio ao laboratório para baciloscopia e cultura.

Especialmente nas pessoas cujo diagnóstico inicial de TB foi confirmado laboratorialmente, considera-se “cura” quando houver registro de duas baciloscopias negativas, sendo uma realizada em qualquer mês do acompanhamento e outra ao final do tratamento (5º ou 6º mês). Nos casos em que há necessidade de ampliação do tempo de tratamento, devem ser considerados os resultados dos dois últimos meses de acompanhamento.

A alta por cura também pode ser atribuída à pessoa que completou o tratamento sem evidência de falência terapêutica e recebeu alta com base em critérios clínicos e radiológicos, nos casos em que não foi possível realizar exames de baciloscopia.

Caso haja registro de persistência de baciloscopia de escarro positiva ao final do tratamento, o caso deve ser avaliado pela equipe assistencial, podendo ser classificado como falência ao tratamento, conforme as diretrizes nacionais.

12. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO – TCI

Não se aplica.

13. REGULAÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO PELO GESTOR

Os atendimentos realizados deverão ser registrados para fins de monitoramento de produção de serviços realizados. No **quadro 9** estão dispostos alguns procedimentos importantes para este protocolo, considerando a temática da TB.

Quadro 9. Procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais especiais do SUS relacionados ao protocolo.

SERVIÇO EXECUTADO	PROCEDIMENTOS DO SIGTAP UTILIZADOS PELO FARMACÊUTICO	CÓDIGO
Consulta farmacêutica	Consulta com identificação de casos novos de tuberculose	03.01.01.002-1
Rastreamento em saúde	Prova tuberculínica (PT)	02.02.03.024-5
	Avaliação de contatos de pessoas com tuberculose	03.01.04.020-6
Acompanhamento farmacoterapêutico	Coleta de material para exame laboratorial	02.01.02.004-1
	Acompanhamento de pessoa em tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose	03.01.04.019-2
Anamnese farmacêutica	Aferição de temperatura	03.01.10.025-0
	Medição de peso	01.01.04.008-3

Fonte: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

O atendimento individual no prontuário eletrônico do cidadão (PEC) e-SUS APS deve obrigatoriamente conter, no módulo “Avaliação”, o CIAP2 e/ou CID-10.

No módulo “Plano”, é obrigatório preencher o campo “Intervenções e/ou procedimentos clínicos

realizados” com o tipo de procedimento realizado, indicando o SIGTAP.

O atendimento coletivo deverá ser registrado através do módulo “Atividade Coletiva” no PEC e-SUS APS, na aba “Atividades em saúde”, preenchendo todos os campos na página “Registro de atividade coletiva em saúde”. Para o monitoramento dessas atividades, os atendimentos coletivos de cidadãos com TB ou em tatamento de ILTB devem ser registrados com as seguintes informações:

1) Data da atividade;
2) Turno;
3) Número de participantes;
4) Local da atividade com registro do CNES;
5) Profissionais envolvidos;
6) Dados da atividade: tipo da atividade, público alvo, temas para a saúde e registro dos participantes.

A escolha do registro de atendimento deve ser feita de acordo com a forma como o serviço foi oferecido ao cidadão. Os atendimentos em grupo devem ser obrigatoriamente registrados como ocorrência de grupos terapêuticos, enquanto os atendimentos individuais devem ser registrados quando o serviço for realizado de forma individual para cada cidadão.

13.1. Evolução

A RDC Anvisa º 44/2009, que trata sobre as Boas Práticas Farmacêuticas, traz em seu §1º, do art. 64, que “as atividades devem ser documentadas de forma sistemática e contínua, com o consentimento expresso do usuário”.

Ainda, conforme art. 65 da mesma RDC, “as ações relacionadas à atenção farmacêutica devem ser registradas de modo a permitir a avaliação de seus resultados”.

Diante de tal normativa, este protocolo traz o método SOAP (acrônimo para **S**ubjetivo, **O**bjetivo, **A**valiação e **P**lano) como ferramenta para orientar o registro e o planejamento das ações e/ou intervenções farmacêuticas. O método de registro SOAP segue os seguintes descritivos (Brasil, 2020b):

- **S** (dados **S**ubjetivos):

  Sintomas e outras informações relatadas pelo paciente, que são de natureza descritiva e que, geralmente, não podem ser confirmadas por exames e testes. São comuns no momento do relato da história social, história clínica e experiência com os medicamentos.

- **O** (dados **O**bjetivos):

  Resultados obtidos nos exames físicos, laboratoriais, testes diagnósticos e inclui fatores de riscos que podem ser medidos por meio de escalas apropriadas para estratificação de risco.

- **A** (**A**valiação):

  Conclusões sobre as necessidades do paciente, particularmente aquelas relacionadas à farmacoterapia, a partir da análise das informações subjetivas e objetivas.

- **P** (**P**lano):

  Contém as informações e orientações prestadas aos usuários e familiares, incluindo sugestões de ajuste da farmacoterapia, reorganização do regime terapêutico, educação em saúde e encaminhamentos a outros profissionais. O plano elaborado pelo farmacêutico deve ser pactuado com o usuário e revisado sempre que necessário, bem como discutido com a equipe de saúde, principalmente se houver alterações da farmacoterapia, e todas intervenções registradas.

O quadro 10 traz as categorias e as informações relacionadas ao método SOAP para este protocolo.

Quadro 10. Categorias e informações para o método de registro SOAP para tuberculose.

Categoria (SOAP)	**Informações para registro**
Dados subjetivos	Descrição dos sintomas (associados ou não); Tempo de início dos sintomas; Preocupações do paciente em relação aos sintomas; Questionário de qualidade de vida Avaliação de: tabagismo, uso de álcool, uso de outras drogas, infecção pelo HIV, diabetes, uso do imunossupressor ou doença imunossupressora, contato de TB ativa, população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, entre outros.
Dados objetivos	Inclui dados do exame físico, peso, altura e sinais vitais; Se houver exames laboratoriais, os resultados devem ser registrados; Lista atual de medicamentos usados para a condição de saúde e outras; Interações medicamentosas encontradas; Dados de farmacocinética relevantes para farmacoterapia.
Avaliação	PRMs Comorbidades descompensadas Queixas não tratadas Qualquer outra situação que necessite de atenção (ex.: vulnerabilidade social, insegurança alimentar).
Plano	Ajustes da farmacoterapia, se necessário; Recomendações a serem feitas e/ou discutidas; Orientações se PRMs; Educação e/ou aconselhamento ao paciente ou a equipe relacionada ao tratamento e à condição de saúde; Registro de metas terapêuticas a serem alcançadas; Parâmetros a serem monitorados; Data para reavaliação paciente.

Fonte: Brasil, 2020b. Ribeirão Preto, 2025.

13.1 Indicador de Educação Permanente

Indicador	Percentual de profissionais capacitados
Conceituação	Esse indicador visa avaliar o percentual de profissionais que conhecem o protocolo e a partir daí, qual a perspectiva de ser implementado.
Limitações	Não considera o tempo de treinamento, nem o conhecimento do profissional; não avalia outros aspectos relevantes para a implementação do protocolo
Fonte	Lista de presença no treinamento
Metodologia de Cálculo	$\frac{\text{nº de profissionais farmacêuticos capacitados}}{\text{nº total de profissionais farmacêuticos}} \times 100$
Periodicidade de monitoramento	Trimestral
Periodicidade de envio à CPPAS	Anual
Unidade de medida	Percentual
Meta	80%
Descrição da Meta	Treinar no mínimo 20% dos profissionais a cada trimestre.

13.2 Indicadores de Resultado

Indicador	Proporção de cura entre casos novos de TB pulmonar com confirmação laboratorial e acompanhamento farmacêutico
Conceituação	Esse indicador visa avaliar o sucesso terapêutico, indicando a resolutividade do tratamento ofertado das pessoas com TB acompanhadas por farmacêutico
Limitações	Não considera influências externas que impactam no atingimento do indicador, como a adesão ao tratamento, interrupções no tratamento por falta de insumos, desfechos desatualizados no sistema, dentre outros
Fonte	Prontuário do TrackCare, e-SUS e Sinan
Metodologia de Cálculo	$\frac{\text{nº de casos novos de TB pulmonar com confirmação laboratorial curados e com acompanhamento farmacêutico}}{\text{nº total de casos novos de TB pulmonar com confirmação laboratorial e acompanhamento farmacêutico}} \times 100$
Periodicidade de monitoramento	Trimestral
Periodicidade de envio à CPPAS	Anual
Unidade de medida	Percentual
Meta	80%
Descrição da Meta	Treinar no mínimo 20% dos profissionais a cada trimestre.

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELO HORIZONTE. Guia de Atuação do Farmacêutico na Tuberculose. 2ª Edição. 2022. Disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/Guia%20de%20atuacao%20do%20farmaceutico%20na%20tuberculose%20-%202%20Ed-atualizacao_05-10-2022.pdf. Acesso em: 4 jun. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Notivisa – Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Saúde. Documento Base 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. VigiMed – Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos. Brasília: Anvisa, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil: 2. ed. atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 364 p.: il. ISBN 978-85-334-2696-2. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf Acesso em: 4 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Ofício Circular nº 3/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS: Orientação sobre o uso das doses fixas pediátricas RHZ (rifampicina 75mg, isoniazida 50mg e pirazinamida 150mg) e RH (rifampicina 75mg e isoniazida 50mg) comprimidos dispersíveis para o tratamento da tuberculose pediátrica. Brasília: Ministério da Saúde, 2020a. Disponível em https://central3.to.gov.br/arquivo/526742/. Acesso em 23 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: aplicação do método clínico. Brasília: Ministério da Saúde, 2020b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasil livre da tuberculose: plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública: estratégias para 2021-2025. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_livre_tuberculose_plano_nacional.pdf. Acesso em: 4 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasil livre da tuberculose: plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública – estratégias para 2021-2025: *versão para a sociedade civil*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/publicacoes/final_plano-nacional-pelo-fim-da-tb_2021-2025.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasil livre da tuberculose: plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública – estratégias para 2021- 2025. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. ISBN 978- 65- 5993- 080- 7. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/tuberculose/brasil-livre-da-tuberculose/view. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Nota informativa nº 5/2021- CGDR/.DCCI/SVS/MS: Dispõe sobre atualização das Recomendações do Tratamento da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis com a disponibilização da rifapentina. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-informativas/2021/nota-informativa-no-5-2021-cgdr-dcci-svs-ms. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Guia orientador: promoção da proteção social para as pessoas acometidas pela tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas – CGTM. Nota informativa nº 20/2023- CGTM/.DATHI/SVSA/MS: Atualização sobre a definição do Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose no contexto da tecnologia de saúde digital. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-informativas/2024/nota-informativa-15-iltb-farmaceuticos.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/ Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Controle de infecção por *M. tuberculosis* em ambientes de saúde [recurso eletrônico]. Brasília: MS, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2023/controle-de-infeccao-por-m-tuberculosis-em-ambientes-de-saude-_-eletronico_leve.pdf/view. Acesso em 23 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas. Nota informativa nº 5/2024- CGTM/.DATHI/SVSA/MS: Implementação do tratamento encurtado datuberculose sensível não grave em crianças eadolescentes (2RHZ (E)/ 2RH). Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-informativas/2024/nota-informativa-no-5-2024-cgtm.pdf/view. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas. Nota informativa nº 15/2024- CGTM/.DATHI/SVSA/MS: Recomendações técnicas aos farmacêuticos para acolher, orientar e prescrever o tratamento da infecção latente da tuberculose (ILTB). Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-informativas/2023/sei_ms-0037162163-nota-informativa-20.pdf/view. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas. Boletim Epidemiológico: Tuberculose 2025. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2025/boletim-epidemiologico-tuberculose-2025/@@download/file. Acesso em: 23 jul. 2025

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Guia para o cuidado farmacêutico na tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/14XB6V9gTSP1clQmWdRzjQM2J7KAxezBx/view. Acesso em: 29 jul. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução CFF nº 585/2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. Brasília: CFF, 2013.

CNS - Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 338 de 06 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 2004.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Resolução nº 602, de 12 de dezembro de 2023. Institui a Política Distrital de Assistência Farmacêutica – PDAF. Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a77a8105599b458e856f259341433ba8/ses_csdf_res_602_2023.html. Acesso em: 4 jun. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Guia de boas práticas para os serviços farmacêuticos desenvolvidos no ambiente hospitalar. Brasília: SES/DF, 2020. Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/es/informativos-diasf/. Acesso em: 4 jun. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Fluxogramas Rápidos: itinerário da pessoa com tuberculose no DF. Brasília: SES/DF, 2026. Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/documents/d/saude/fluxograma_revisado_final_10_06_2026-pdf. Acesso em: 29 jul. 2026.

Rede Brasileira de Comitês de Tuberculose. Proteção Social. Disponível em https://www.redebrasileiradecomites.com/prote%C3%A7%C3%A3o-social. Acesso em 23 jul. 2025.

RIBEIRÃO PRETO. Prefeitura da Cidade. Secretaria Municipal de Saúde. Manual de Consulta Farmacêutica: Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto, 2025. p. 75.

Teixeira LM, Palmeira IP, Matos WDV, Sousa RF, Monteiro YC, Vale CC, Oliveira LL. Concepções sobre tratamento e diagnóstico da tuberculose pulmonar para quem a vivencia. Esc. Anna. Nery n. 27, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization, 2024. Disponível em: https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024. Acesso em: 23 jul. 2025.

ELABORADORES(AS) E REVISORES(AS)

ELABORADORES(AS):

- Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger
- Raiane Diniz Oliveira
- Nicole Menezes de Souza
- Fernanda Duarte de Andrade

REVISORES(AS):

- Jéssica do Amaral Dutra
- Jussara Aparecida Costa Brandão
- Sandra Alves
- Ricardo Gadelha

APÊNDICE 1

Etapas Sugeridas para o Cuidado Farmacêutico à Pessoa com Tuberculose (TB ativa)

ETAPAS DO CUIDADO	SERVIÇO DO CUIDADO FARMACÊUTICO	OBSERVAÇÕES PRINCIPAIS
Promoção da saúde e prevenção	Educação em saúde	Orientações sobre transmissão, estigma, adesão e importância do tratamento
Acesso e primeiro contato	Anamnese farmacêutica	Coleta de dados clínicos, sociais, sinais e sintomas, peso, histórico medicamentoso
	Análise técnica da prescrição	Verificação de dose, posologia, segurança e legalidade da prescrição
	Dispensação	Entrega dos medicamentos e orientações práticas
Avaliação clínica e diagnóstico situacional	Revisão da farmacoterapia	Avaliação de indicação, efetividade, segurança e adesão
	Consulta farmacêutica	Atendimento clínico com planejamento de cuidado
	Reconciliação medicamentosa	Se for retratamento, ou múltiplas prescrições ou alta hospitalar
	Prevenção e identificação de erros de medicação	Avaliação de duplicidades, interações ou falhas
	Eventos adversos / Desvio de qualidade	Detecção e notificação
Intervenção e cuidado direto	Manejo de problemas autolimitados	Náuseas, efeitos leves, sintomas que não exigem condutas médicas
	Gestão da condição de saúde	Participação no Projeto Terapêutico Singular (PTS)
Acompanhamento e monitoramento	Acompanhamento farmacoterapêutico	Acompanhamento mensal, tratamento diretamente observado (TDO), avaliação clínica contínua
	Monitorização terapêutica de medicamentos	Avaliação de exames laboratoriais (quando indicado)
Encerramento do ciclo de cuidado	Orientação farmacêutica de alta	Orientações pós-tratamento, vigilância de efeitos tardios, reforço de autocuidado

Fonte: autoria própria.

APÊNDICE 2

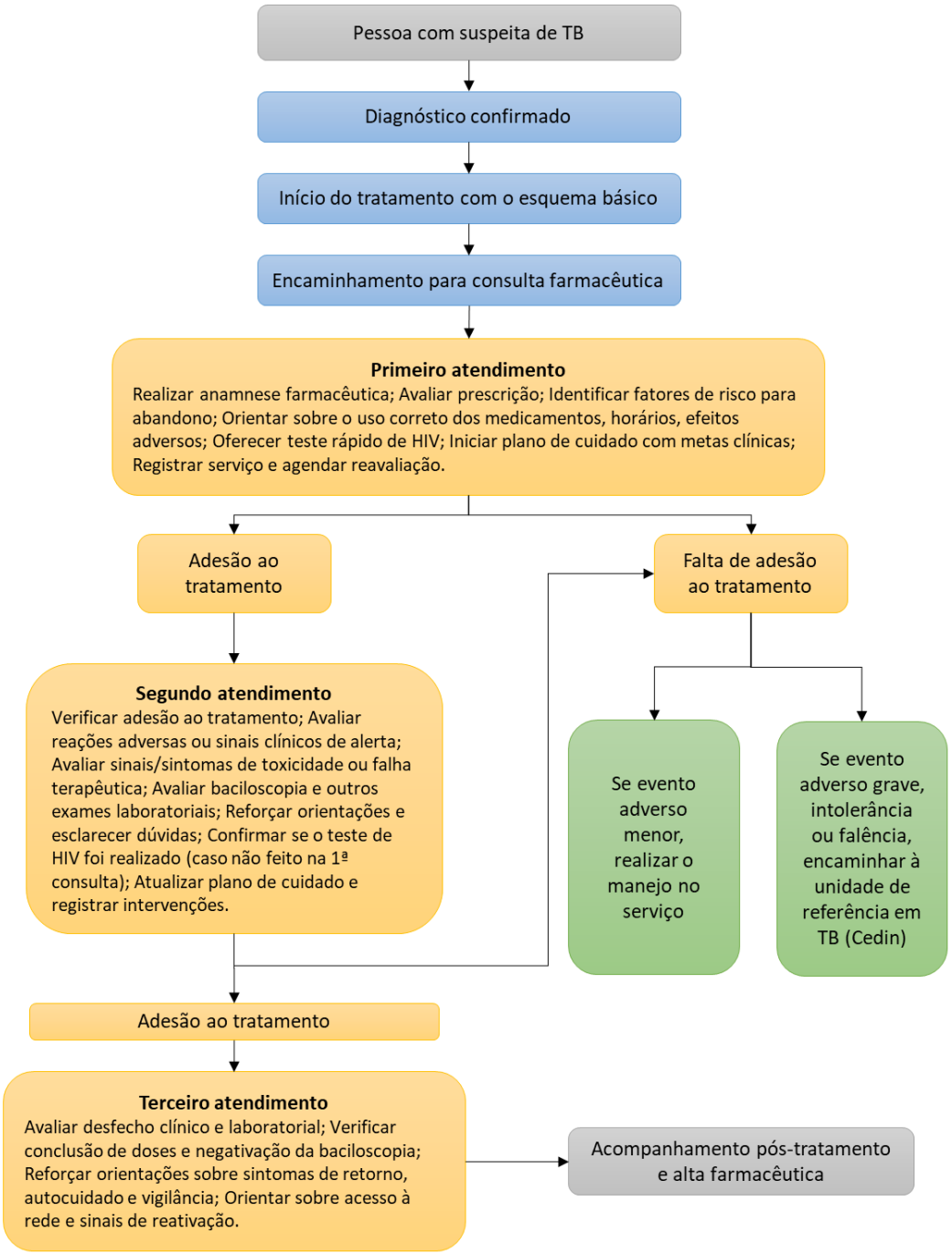
Etapas Sugeridas para o Cuidado Farmacêutico à Pessoa com Infecção Latente por TB (ILTB)

ETAPAS DO CUIDADO	SERVIÇO DO CUIDADO FARMACÊUTICO	OBSERVAÇÕES PRINCIPAIS
Promoção da saúde e prevenção	Educação em saúde	Informação sobre a ILTB, importância da prevenção da doença ativa
	Rastreamento em saúde	Busca ativa de contatos e pessoas em situação de vulnerabilidade
	Práticas Integrativas em Saúde	Apoio à adesão (ex.: manejo dos efeitos adversos menores)
Acesso e primeiro contato	Anamnese farmacêutica	Coleta de histórico de saúde, uso de medicamentos, peso, exames prévios
	Análise técnica da prescrição	Prescrição para ILTB (como o 3HP, 4R, 6H)
	Dispensação	Entrega e orientações sobre armazenamento e tomada correta dos medicamentos
Avaliação clínica e diagnóstico situacional	Revisão da farmacoterapia	Avaliação da indicação (critério de ILTB), esquema, duração e segurança
	Consulta farmacêutica	Atendimento clínico, principalmente nos momentos de início e meio do tratamento
Intervenção e cuidado direto	Prescrição farmacêutica	Realizar prescrição e ajuste de prescrição conforme protocolos oficiais
	Gestão da condição de saúde	Propor metas, estratégias para adesão, vigilância de efeitos adversos
Acompanhamento e monitoramento	Acompanhamento farmacoterapêutico	Avaliação de adesão, efeitos adversos, orientação contínua
Encerramento do ciclo de cuidado	Orientação farmacêutica de alta	Verificação de doses tomadas e reforço para sinais de alerta

Fonte: autoria própria.

APÊNDICE 3

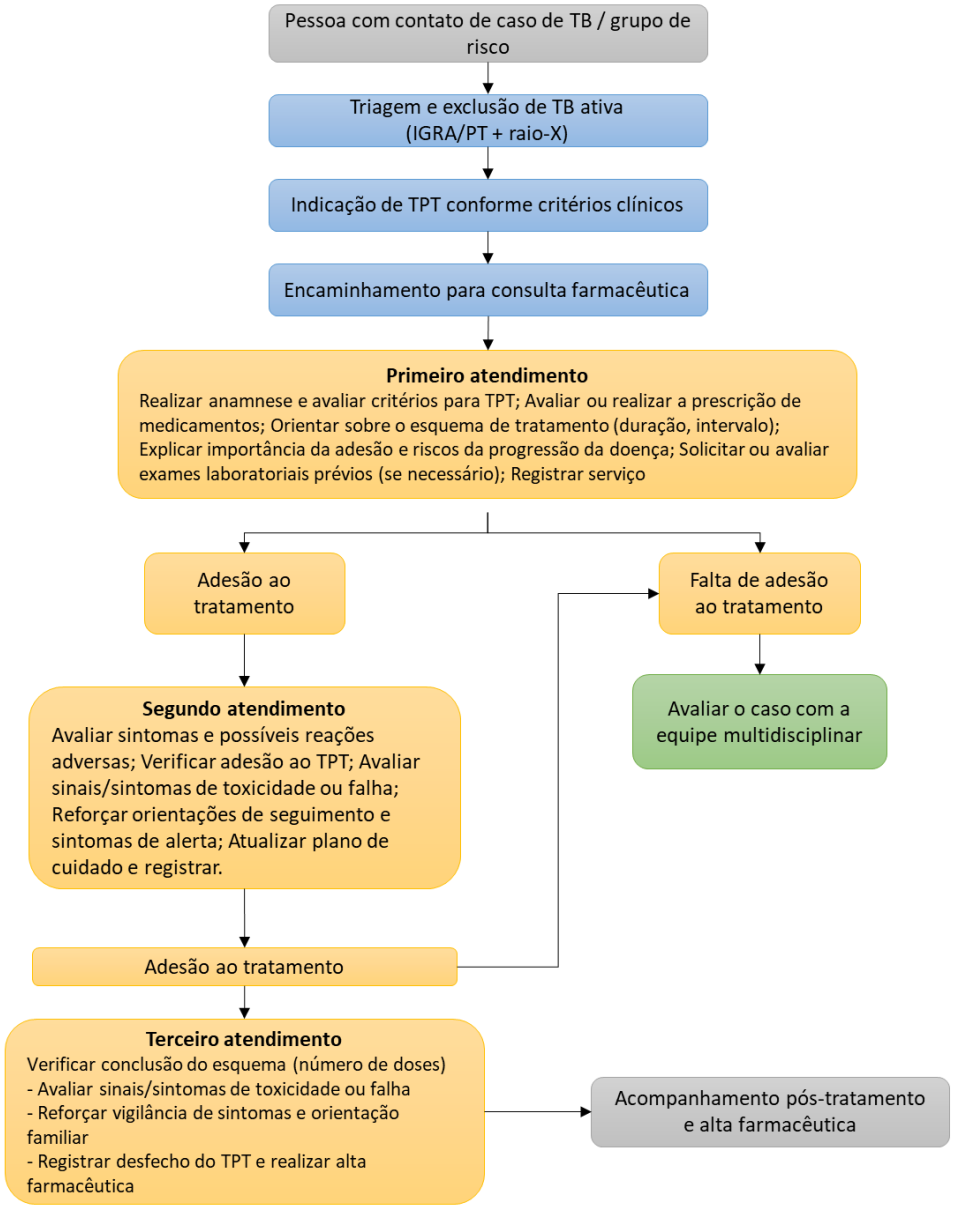
Fluxo do cuidado farmacêutico à pessoa com TB sensível



Fonte: autoria própria.

APÊNDICE 4

Fluxo do cuidado farmacêutico à pessoa com ILTB



Educação em saúde / PICs / Enfrentamento do estigma e discriminação

Fonte: autoria própria.

APÊNDICE 5

Questionário de Qualidade de Vida

Este questionário avaliará sua qualidade de vida com 5 questões que envolvem os 5 principais itens que influenciam a qualidade de vida.

1. Para cada item abaixo, por favor marque UMA opção que melhor descreve a sua saúde hoje:

MOBILIDADE

- Eu não tenho problemas em andar ☐
- Tenho alguns problemas em andar ☐
- Estou limitado a ficar na cama ☐

CUIDADOS PESSOAIS

- Eu não tenho problemas com meus cuidados pessoais ☐
- Eu tenho alguns problemas para me lavar ou me vestir ☐
- Eu sou incapaz de me lavar ou me vestir sozinho ☐

ATIVIDADES HABITUAIS (ex. trabalho, estudo, atividades domésticas, atividades em família ou de lazer)

- Eu não tenho problemas em desempenhar minhas atividades habituais ☐
- Eu tenho alguns problemas em desempenhar minhas atividades habituais ☐
- Eu sou incapaz de desempenhar minhas atividades habituais sozinho ☐

DOR / DESCONFORTO

- Eu não tenho dor ou desconforto ☐
- Eu tenho dor ou desconforto moderado ☐
- Eu tenho dor ou desconforto extremo ☐

ANSIEDADE / DEPRESSÃO

- Eu não estou ansioso ou deprimido ☐
- Eu estou moderadamente ansioso ou deprimido ☐
- Eu estou extremamente ansioso ou deprimido ☐

2. Nós gostaríamos de saber quão bom ou ruim está sua saúde HOJE.

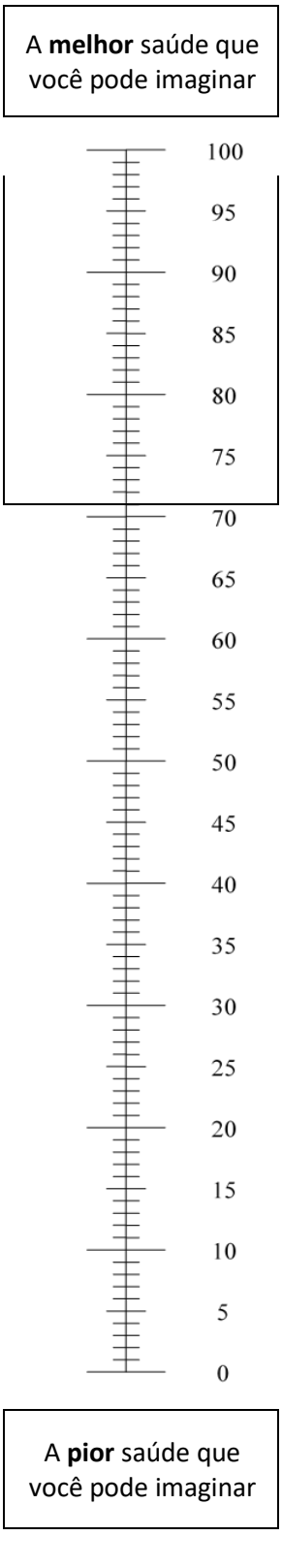
Essa escala é numerada de 0 a 100, sendo que:

- 100 (cem) significa a melhor saúde que você pode imaginar
- 0 (zero) significa a pior saúde que você pode imaginar

<u>Marque um X</u> na escala ao lado para indicar como está a sua saúde HOJE

Agora, por favor escreva na caixa abaixo o número que você marcou na escala.

SUA SAÚDE HOJE = ☐



APÊNDICE 6
Anamnese Farmacêutica (TB e ILTB)

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL		
Nome:		
Nome social:		
Data de nascimento: _____ / _____ / _____		**Sexo:** [ ] Feminino [ ] Masculino
Endereço completo:		
Nº CNS / Nº SES:	**Nº SINAN:**	
Gênero: [ ] Homem [ ] Mulher [ ] Não binário		**Peso atual (Kg):**
Escolaridade:		
[ ] Nenhuma	[ ] Fundamental incompleto	[ ] Fundamental completo
[ ] Médio incompleto	[ ] Médio completo	[ ] Superior incompleto
[ ] Superior completo		
Profissão:		
CONDIÇÃO DE SAÚDE		
Diagnóstico: [ ] TB pulmonar [ ] TB extrapulmonar [ ] ILTB		
Data do diagnóstico: _____ / _____ / _____		
Sinais e sintomas presentes:		
[ ] Nenhum	[ ] Tosse sem tempo definido	[ ] Tosse menos de 3 semanas
[ ] Tosse mais de 3 semanas	[ ] Febre	[ ] Falta de apetite
[ ] Perda de peso	[ ] Suor à noite	[ ] Cansaço
[ ] Outros: _____		
Doenças e/ou agravos concomitantes (comorbidades):		
[ ] HIV/aids	[ ] Diabetes	[ ] Tabagismo
[ ] Uso de álcool	[ ] Uso de outras drogas	[ ] Depressão e/ou ansiedade
[ ] Outras: _____		
Resultados de outros exames laboratoriais		
1. Hemograma		Data do exame: _____ / _____ / _____
Hemácias:	Hemoglobina:	Hematócrito:
VCM:	HCM:	CHCM:
Leucócitos:	Basófilos:	Eosinófilos:
Mielócitos:	Metamielócitos:	Bastões:
Segmentados:	Linfócitos:	Atípicos:
Monóticos:	Plaquetas:	

2. Função hepática Data do exame: _____ / _____ / _____

Bilirrubinas: Proteínas totais: Albumina:

TGO/AST: TGP/ALT: Gama GT:

3. Função renal Data do exame: _____ / _____ / _____

Creatinina: Ácido úrico:

4. Hemoglobina glicada Data do exame: _____ / _____ / _____

HbA1c: Glicemia média:

5. Glicemia Data do exame: _____ / _____ / _____

Glicemia de jejum:

PRINCIPAIS QUEIXAS

Queixas gerais:

Queixas relacionadas aos sintomas e sinais clínicos de TB ativa:

Queixas que podem sugerir reações adversas ou intolerância medicamentosa:

HISTÓRICO DO USO DE MEDICAMENTOS, AUTOMEDICAÇÃO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS

Listar todos os medicamentos em uso ou outros (descrever nome, indicação, posologia em uso, data de início do tratamento):

RESULTADO DOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO

Pessoa com TB:

1. TRM-TB Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Detectado, RIF sensível [ ] Detectado, RIF resistente [ ] Detectado, RIF indeterminado

[ ] Detectado, traços [ ] Não detectado [ ] Erro/Indeterminado

[ ] Não realizado [ ] Em andamento

2. Baciloscopia de diagnóstico Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Positivo, 1 a 9 bacilos [ ] Positivo + [ ] Positivo ++

[ ] Positivo +++ [ ] Não detectado / negativo [ ] Não realizado

[ ] Em andamento

3. Cultura — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Positivo [ ] Positivo + [ ] Positivo ++

[ ] Não realizado [ ] Em andamento

4. Teste de sensibilidade — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Sensível [ ] Resistente (listar os fármacos resistentes):

[ ] Não realizado [ ] Em andamento

5. Baciloscopia de acompanhamento — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Positivo, 1 a 9 bacilos [ ] Positivo + [ ] Positivo ++

[ ] Positivo +++ [ ] Não detectado / negativo [ ] Não realizado

[ ] Em andamento

Pessoa com ILTB:

1. IGRA — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Positivo / reagente [ ] Negativo / não reagente [ ] Indeterminado

[ ] Não realizado [ ] Em andamento

2. Prova tuberculínica (PT) — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] ≥ 5 mm [ ] < 5 mm [ ] ≥ 10 mm

[ ] < 10 mm [ ] Não realizado [ ] Em andamento

3. Raio-X de tórax — Data do exame: _____ / _____ / _____

[ ] Sem alterações sugestivas de TB [ ] Com alterações sugestivas de TB

[ ] Não realizado [ ] Em andamento